BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền

Bản rà soát hoàn thiện để trình thẩm định năm 2026

Ngày rà soát 15/10/2026. Gồm 22 quy trình từ tài liệu bệnh viện cung cấp. Giữ nội dung chuyên môn phù hợp, hình minh họa và bảng huyệt; chuẩn hóa đề cương 7 phần, mục chuẩn bị 5.1–5.9 theo QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023. Bản gốc giữ nguyên.

Chưa phải văn bản đã ban hành. Khoa và Hội đồng chuyên môn xác nhận danh mục, thời điểm áp dụng, nhân lực, thuốc, thiết bị và phác đồ trước trình người có thẩm quyền phê duyệt. Không tự điền số quyết định, người ký hoặc ngày hiệu lực của bệnh viện.

Nội dung	Xác nhận
Người rà soát	……
Người thẩm định chuyên môn	……
Người phê duyệt	……
Quyết định và ngày hiệu lực	……

Căn cứ và nội dung cần xác nhận trước ban hành

QĐ3023/QĐ-BYT điều chỉnh đề cương và thể thức; căn cứ chuyên môn là hướng dẫn tương ứng theo QĐ486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026. Đã tra cứu bản toàn văn do bệnh viện công lập công bố và đối chiếu nguyên tắc áp dụng cùng các nội dung trọng điểm trong bản nguồn; không coi QĐ3023 quy định mọi thao tác lâm sàng.

QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026 sửa Điều 3 QĐ486: nhóm kỹ thuật có trong Phụ lục 02 nhưng không có trong Phụ lục 01 Thông tư 23/2024/TT-BYT thực hiện từ 01/01/2028. Nhóm chỉ có trong Phụ lục 01 tiếp tục đến khi được thay thế hoặc bãi bỏ. Không suy diễn toàn bộ QĐ486 bị hoãn đến năm 2028.

Riêng hai quy trình cấy chỉ nâng cơ vùng mặt và vùng cơ thể: giữ ở mức dự thảo chờ xác nhận đối chiếu danh mục, thời điểm và phạm vi kỹ thuật. Không xem việc có mặt trong bộ này là cho phép triển khai năm 2026. Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp khoa kiểm tra giấy phép, danh mục được phê duyệt và quy định chuyển tiếp trước trình áp dụng.

Nhân lực phải đồng thời đáp ứng phạm vi hành nghề, năng lực, đào tạo hoặc chuyển giao khi được yêu cầu, phân công và điều kiện cơ sở. Chứng chỉ đào tạo đơn lẻ không thay giấy phép hoặc tự mở rộng phạm vi. Châm tê trong danh sách chỉ định không thay quy trình vô cảm riêng.

Đã sửa lỗi phông chữ, số thứ tự, từ lặp và đơn vị; bổ sung kiểm tra định danh, thuốc, an toàn điện và nhiệt, đếm kim, xử trí ngất, ngộ độc thuốc tê và theo dõi sau thủ thuật. Những điểm điều chỉnh là nội dung đề xuất của bệnh viện để thẩm định, không trình bày như trích nguyên văn Bộ Y tế.

Nội dung nguồn ghi mốc 2–3 cm cho vật liệu cứu trẻ nhi không thống nhất với phần chuẩn bị 2–3 mm; bản này dùng mức ở phần chuẩn bị và yêu cầu khoa xác nhận trước áp dụng. Thời gian, số lần và liều trong nguồn là mốc chuyên môn tham khảo, phải cá thể hóa theo chỉ định; bảng liều laser cần xác nhận theo đúng thiết bị.

Nguồn đã đối chiếu

1. QĐ486/QĐ-BYT, bản toàn văn công bố trên trang Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh. Nguồn đối chiếu

2. Trung tâm Y tế Pleiku công bố QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026. Nguồn đối chiếu

3. Nội dung QĐ2149 đối chiếu tại Thư viện Pháp luật; tệp đính kèm nguồn công lập chưa tải được trong lần rà soát. Nguồn đối chiếu

4. ASRA, bảng kiểm ngộ độc thuốc tê toàn thân 2020, nguồn quốc tế đối chiếu. Nguồn đối chiếu

5. OSHA, an toàn laser và kính bảo vệ; nguồn quốc tế đối chiếu. Nguồn đối chiếu

Phản vệ thực hiện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT và phác đồ bệnh viện. Hướng dẫn KSNK, tiêm an toàn và sử dụng thuốc của bệnh viện áp dụng đồng thời. Tài liệu cũ năm 2013 và 2020 trong nguồn được giữ để truy nguyên; không coi mọi quy trình cũ vẫn còn hiệu lực sau QĐ486.

Danh mục 22 quy trình

01 Bó thuốc y học cổ truyền
02 Cấy chỉ điều trị
03 Cấy chỉ nâng cơ vùng mặt
04 Cấy chỉ nâng cơ vùng cơ thể trừ mặt
05 Chườm thuốc cổ truyền
06 Cứu ngải
07 Cứu ngải trẻ nhi
08 Điện châm
09 Điện châm trẻ nhi
10 Điện mãng châm
11 Giác hơi
12 Hào châm
13 Mãng châm đại trường châm
14 Kéo nắn cột sống cổ bằng phương pháp y học cổ truyền
15 Kéo nắn cột sống thắt lưng theo phương pháp y học cổ truyền
16 Laser châm
17 Ngâm thuốc y học cổ truyền bộ phận
18 Ôn châm
19 Thủy châm tiêm thuốc vào huyệt
20 Xoa bóp bấm huyệt
21 Xoa bóp bấm huyệt cho trẻ nhi
22 Cạo gió

01 Bó thuốc y học cổ truyền

Mã đề xuất QT YHCT 01 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Bó thuốc y học cổ truyền (bó thuốc cổ truyền) là phương pháp chữa ngoài của y học cổ truyền, đưa thuốc thẩm thấu qua da tác động trực tiếp lên các huyệt vị, các tổ chức phần mềm, một số khớp trên cơ thể nhằm mục đích khu phong, tán hàn, trừ thấp, hoạt huyết, tiêu viêm, lưu thông kinh lạc.

2 Chỉ định

Bong gân, trật khớp đã được nắn chỉnh.

Rạn xương, gãy xương đã được nắn chỉnh.

Gãy xương đã phẫu thuật kết hợp xương.

Thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống.

Thoát vị đĩa đệm cột sống không có chỉ định ngoại khoa.

Viêm khớp không do nhiễm khuẩn.

3 Chống chỉ định

Người bệnh có vết thương hở, bệnh lý ngoài da vùng cần bó thuốc.

Gãy xương hở.

Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.

Người bệnh có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc.

4 Thận trọng

Người bệnh có cơ địa dị ứng.

Người bệnh tâm thần, động kinh, rối loạn cảm giác, người già sa sút trí tuệ.

Trẻ em dưới 24 tháng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật bó thuốc cổ truyền thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Thuốc cổ truyền có tác dụng điều trị phù hợp với chỉ định:

Đối với thuốc bó là thuốc tươi: làm sạch, giã nát, sao, tẩm rồi bọc vào băng, gạc.

Đối với thuốc cổ truyền được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành: thực hiện theo hướng dẫn sử dụng.

Thuốc cổ truyền đã được bào chế thành dạng phù hợp theo y lệnh.

5.3 Vật tư

Gạc y tế, bông gòn vô trùng, khăn sạch.

Găng tay, khẩu trang.

Băng keo dán cố định.

Khay đựng thuốc.

Băng co dãn.

Nilon lót dưới vùng bó. Khăn vải rộng hơn vùng bó để giữ nhiệt.

Dây vải cố định.

Nhiệt kế.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ giã, xay thuốc.

Dụng cụ làm nóng thuốc: Lò vi sóng, bếp, …

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, …

Vệ sinh sạch sẽ vùng bó thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Bệnh án chẩn đoán hoặc sổ khám bệnh chẩn đoán, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và phiếu chỉ định của bác sĩ.

Cần ghi rõ chỉ định, ngày giờ bó, tình trạng thăm khám toàn thân, hướng xử trí, những điều dặn dò và liệu trình.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp cộng hưởng từ, X-Quang khớp (nếu cần).

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Từ 30 đến 60 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Lựa chọn dạng thuốc theo chỉ định: thuốc có dạng bào chế được phép lưu hành, thuốc bào chế truyền thống hoặc thuốc tươi đã được chuẩn bị, kiểm soát chất lượng phù hợp; ghi tên, thành phần, lượng và cách dùng. Không coi mọi dạng thuốc có thể thay thế nhau.

Bước 1: Sát khuẩn tay.

Bước 2: Kiểm tra trước khi tiến hành bó: kiểm tra mạch máu, thần kinh, màu sắc da của vùng bó.

Bước 3: Bó thuốc.

Trải tấm nilon dưới vùng bó (nếu cần).

Tiến hành bó thuốc: đặt thuốc lên vị trí cần bó, cố định thuốc bó.

Bước 4: Cố định lại vị trí tổn thương nếu cần.

Bước 5: Kiểm tra sau bó.

Kiểm tra mạch máu, thần kinh, độ ấm của chi, màu sắc da, vận động khớp trên và dưới vùng bó. Kiểm tra lưu thông tuần hoàn vùng bó, nới lỏng vùng bó nếu cần.

Bước 6: Kết thúc quy trình.

Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi thực hiện thủ thuật.

Thông báo và dặn dò người bệnh: thời gian tháo thuốc bó và liệu trình điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Xử lý dụng cụ sau bó thuốc.

1 liệu trình từ 5 - 7 ngày, có thể thực hiện nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện thủ thuật.

Đau tăng lên:

+ Nếu do bó thuốc chặt: nới lỏng vị trí bó.

Nếu đau do tiến triển tổn thương: ngừng để thăm khám lại, đánh giá tuần hoàn và thần kinh, báo bác sĩ xác định nguyên nhân; thuốc chỉ theo y lệnh.

Tùy theo nguyên nhân đau tăng, thầy thuốc có phương pháp xử trí phù hợp.

Mẩn ngứa, dị ứng da vùng đắp thuốc, tiến hành tháo thuốc, làm sạch vùng da bó thuốc, chuyển sang phương pháp điều trị khác. Uống thuốc dị ứng nếu cần.

Bỏng: xử trí bỏng các cấp độ theo hướng dẫn điều trị bỏng.

Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2008). Bệnh học Ngoại - Phụ Y học cổ truyền (Sách đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền NXB Y học, Hà Nội.

Đặng Kim Châu (1991). Quá trình liền xương, Bách khoa thư bệnh học I, Trung tâm Quốc gia biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

02 Cấy chỉ điều trị

Mã đề xuất QT YHCT 02 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Cấy chỉ là phương pháp châm cứu kết hợp cổ truyền với y học hiện đại, được tiến hành bằng cách đưa chỉ tự tiêu vào huyệt để phòng và chữa bệnh.

2 Chỉ định

Các bệnh lý thần kinh: Liệt nửa người do đột quỵ, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, liệt tứ chi, đau thần kinh tọa, hội chứng cổ vai cánh tay, đau thần kinh liên sườn, động kinh, bại não, ...

Cơ xương khớp: Đau cổ gáy, viêm quanh khớp vai, đau lưng, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, viêm khớp dạng thấp, ...

Hô hấp: Hen phế quản, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, khàn tiếng, ...

Tim mạch: Huyết áp thấp, tăng huyết áp, …

Tiêu hóa: Hội chứng dạ dày - tá tràng, táo bón, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích, ...

Tiết niệu - sinh dục: Đau bụng kinh, hội chứng tiền mãn kinh, di tinh, liệt dương, tiểu không tự chủ, ...

Da liễu: Mày đay, vảy nến, viêm da cơ địa, ...

Khác: Mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh, thiểu năng tuần hoàn não, giảm thính lực, tự kỷ, cai nghiện ma túy, thuốc lá, rượu, ...

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Dị ứng với loại chỉ được chỉ định cấy.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, mắc bệnh lý tâm thần.

Da vùng cấy chỉ bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng cấy chỉ.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Trường hợp đã can thiệp thẩm mỹ vùng được cấy chỉ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

Thuốc có tác dụng gây tê (lidocaine, ...) hoặc thuốc theo hướng dẫn chuyên môn hoặc các phương pháp vô cảm khác (khi cần thiết).

Bác sĩ ghi loại, nồng độ, tổng thể tích và tổng liều thuốc tê; đối chiếu giới hạn theo cân nặng, bệnh nền, đường dùng và nhãn thuốc. Chuẩn bị phương án xử trí ngộ độc thuốc tê, không dùng thời gian chờ hay liều chung cho mọi chế phẩm.

5.3 Vật tư

Kim cấy chỉ và chỉ tự tiêu; hoặc đầu kim lấy thuốc, kim đẩy chỉ và chỉ tự tiêu; hoặc chỉ liền kim đảm bảo vô trùng.

Bông, cồn sát trùng hoặc cồn i ốt, thuốc gây tê tại chỗ.

Gạc vô trùng, băng dính hoặc băng cá nhân vô trùng.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Găng tay vô khuẩn, găng tay y tế, khẩu trang y tế.

5.4 Trang thiết bị

Panh, kéo.

Khay đựng dụng cụ, kẹp không mấu, kẹp đầu nhọn.

Lọ thủy tinh, khay thủy tinh đựng chỉ.

Bộ dụng cụ đo huyết áp.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được cấy chỉ.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

30 - 45 phút/ lần đối với các trường hợp không sử dụng thuốc gây tê.

50 - 60 phút/lần đối với các trường hợp sử dụng thuốc gây tê, chỉ định thuốc gây tê tùy thuộc vào đánh giá của bác sĩ đối với ngưỡng chịu đau của người bệnh (một vùng hoặc toàn bộ), trong đó: thời gian chờ thuốc tê có tác dụng: khoảng 30 phút; thời gian thực hiện: 20 - 30 phút/lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bác sĩ lựa chọn và ghi đầy đủ huyệt, bên, số lượng, loại chỉ và mục tiêu vào phiếu chỉ định trước thực hiện; không cấy khi phác đồ chưa được ghi hoặc chưa xác nhận.

Các bước thực hiện:

Trường hợp sử dụng chỉ tự tiêu tách rời kim cấy chỉ: Bước 1: Rửa tay sạch, đeo khẩu trang, đi găng tay vô khuẩn.

Bước 2: Sử dụng thuốc tê có dạng bào chế phù hợp với vùng thực hiện thủ thuật.

Chờ thời gian thuốc tê có tác dụng, sau đó làm sạch vùng thuốc tê.

Bước 3: Cắt chỉ tự tiêu thành từng đoạn dài theo vị trí của huyệt. Luồn chỉ vào nòng kim.

Bước 4: Xác định huyệt và sát trùng vùng huyệt cấy chỉ.

Bước 5: Châm kim nhanh qua da và đưa kim từ từ vào huyệt.

Bước 6: Đặt bông vô trùng lên huyệt vừa cấy chỉ, ấn tay xuống rồi rút kim ra, sát trùng lại vùng huyệt vừa cấy chỉ bằng bông vô khuẩn. Dán băng vô trùng lên huyệt vừa cấy chỉ. Tiếp tục thực hiện với các huyệt còn lại theo phác đồ.

Bước 7: Thu dọn dụng cụ, rửa tay và theo dõi người bệnh.

Trường hợp sử dụng chỉ liền kim:

Bước 1: Rửa tay sạch, đeo khẩu trang, đi găng tay vô khuẩn.

Bước 2: Sử dụng thuốc tê có dạng bào chế phù hợp với vùng thực hiện thủ thuật.

Chờ thời gian thuốc tê có tác dụng, sau đó làm sạch vùng thuốc tê.

Bước 3: Xác định huyệt và sát trùng vùng huyệt cấy chỉ. Châm kim nhanh qua da và đưa chỉ từ từ vào huyệt.

Bước 4: Nhẹ nhàng rút kim ra, chỉ đã nằm lại trong huyệt. Sát trùng lại vùng huyệt vừa cấy chỉ bằng bông vô khuẩn. Dán băng vô trùng lên huyệt vừa cấy chỉ. Tiếp tục thực hiện với các huyệt còn lại theo phác đồ.

Bước 5: Thu dọn dụng cụ, rửa tay và theo dõi người bệnh.

Kết thúc quy trình:

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị:

Cân nhắc liệu trình tiếp theo theo thời gian tự tiêu do nhà sản xuất công bố, tình trạng mô tại chỗ và đáp ứng; không lặp lại máy móc khi còn viêm hoặc bất thường.

Tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

Sau cấy chỉ vẫn có thể tiếp tục điều trị bằng châm cứu nếu có bệnh lý khác (Phác đồ huyệt châm cứu không trùng với huyệt đã cấy chỉ).

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Phản vệ: Xử trí phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu sau khi rút kim: Dùng bông khô vô khuẩn ấn cầm máu tại chỗ, không day.

Đau sưng nơi cấy chỉ: chườm lạnh, dùng thuốc chống viêm giảm phù nề hoặc kháng sinh (nếu cần).

Biến chứng muộn:

Một số vị trí đầu chỉ lồi trên mặt da. Xử trí: rút đầu chỉ ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

03 Cấy chỉ nâng cơ vùng mặt

Mã đề xuất QT YHCT 03 Phiên bản trình thẩm định 1.0

Dự thảo chờ xác nhận danh mục và thời điểm áp dụng theo QĐ2149; chưa xác nhận đủ điều kiện triển khai tại bệnh viện năm 2026.

1 Đại cương

Cấy chỉ là phương pháp châm cứu kết hợp cổ truyền với y học hiện đại, được tiến hành bằng cách đưa chỉ tự tiêu vào huyệt để phòng và chữa bệnh.

Theo Y học cổ truyền, vùng mặt là nơi hội tụ của sáu kinh dương và là nơi phản chiếu của khí huyết tạng phủ. Quá trình lão hóa gắn liền với sự suy giảm thiên quý

và công năng ngũ tạng. Cụ thể, Tỳ hư gây thiếu dưỡng cơ nhục, làm mất độ đàn hồi, dẫn đến chảy xệ và nếp nhăn sâu. Can huyết hư khiến da khô, thiếu độ ẩm, xuất hiện các nếp nhăn li ti (vết chân chim đuôi mắt), cân cơ yếu. Thận là gốc của tiên thiên, Thận suy, gây lão hóa sâu, da tối màu, sạm đen, khô héo từ bên trong. Trúng phong kinh lạc lâu ngày cơ mặt bị liệt và chảy xệ. Khí huyết hư không nuôi dưỡng được da và cơ cũng làm da cơ mất căng bóng và chảy xệ.

Cấy chỉ có tác dụng bổ Can Thận, kiện Tỳ Vị, điều hòa khí huyết và kinh mạch ở vùng mặt. Cấy chỉ nâng cơ vùng mặt là thủ thuật đưa các đoạn chỉ tự tiêu bằng kim hoặc ống dẫn chuyên dụng vào dưới da và/hoặc lớp dưới hạ bì hoặc trung gian giữa lớp bì và cơ theo hướng chuyển động sinh lý của cơ. Các nghiên cứu cho thấy cấy chỉ vào huyệt vị tạo ra các “vi tổn thương” làm tăng vi tuần hoàn máu nuôi da, đồng thời kích thích nguyên bào sợi giúp tăng sinh collagen và elastin, làm đầy rãnh nhăn tự nhiên.

2 Chỉ định

Tình trạng thừa da và thừa mô dưới da;

Bệnh nhão da người già;

Liệt Bell; Bệnh khác của dây thần kinh mặt; Bệnh dây thần kinh mặt, không đặc hiệu;

Lão suy do tuổi già;

Nhược cơ (Nuy chứng);

Loạn dưỡng cơ;

Sụp mi.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Dị ứng với loại chỉ được chỉ định cấy.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, mắc bệnh lý tâm thần.

Da vùng cấy chỉ bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng cấy chỉ.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Người có can thiệp thẩm mỹ ở vùng cấy chỉ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và có chứng chỉ hoặc chứng nhận Cấy chỉ nâng cơ vùng mặt chuyên ngành y học cổ truyền do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp hoặc được chuyển giao kỹ thuật và được

người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép bằng văn bản.

Nhân lực hỗ trợ:

Điều dưỡng đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng chạy ngoài.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

Thuốc có tác dụng gây tê (lidocaine, ...) hoặc thuốc theo hướng dẫn chuyên môn hoặc các phương pháp vô cảm khác.

Bác sĩ ghi loại, nồng độ, tổng thể tích và tổng liều thuốc tê; đối chiếu giới hạn theo cân nặng, bệnh nền, đường dùng và nhãn thuốc. Chuẩn bị phương án xử trí ngộ độc thuốc tê, không dùng thời gian chờ hay liều chung cho mọi chế phẩm.

5.3 Vật tư

Chỉ liền kim đảm bảo vô trùng.

Kim cấy chỉ và chỉ tự tiêu; hoặc đầu kim lấy thuốc, kim đẩy chỉ và chỉ tự tiêu.

Bơm tiêm dùng một lần.

Bông, cồn sát trùng và cồn i ốt, nước muối sinh lý.

Gạc vô trùng, băng dính hoặc băng vô trùng.

Săng vô khuẩn có lỗ và không có lỗ.

Xà phòng, nước sạch và dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Găng tay vô khuẩn, găng tay y tế, khẩu trang y tế, mũ trùm đầu y tế.

Dung dịch làm sạch da vùng mặt.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ đựng bông vô khuẩn.

Bộ dụng cụ đo huyết áp.

Panh có mấu, kéo.

Khay đựng dụng cụ, kẹp không mấu, kẹp đầu nhọn.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được cấy chỉ.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian chờ thuốc tê theo dạng bào chế và hướng dẫn thuốc được lựa chọn; mốc khoảng 30 phút trong nguồn không áp dụng chung cho mọi phương pháp vô cảm.

Thời gian thực hiện: 20 - 30 phút/lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng vô khuẩn theo quy định.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, phác đồ huyệt, vị trí cấy chỉ, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Phác đồ huyệt

Huyệt tại chỗ:

Huyệt nhóm 1	Huyệt nhóm 2	Huyệt nhóm 3
+ Thái dương	+ Quyền liêu	+ Hạ quan
+ Giáp xa	+ Dương bạch	+ Địa thương
+ Ế phong	+ Nghinh hương	+ Thừa tương
+ Tình minh	+ Toản trúc	+ Đồng tử liêu
+ Đầu duy	+ Cự liêu	+ Thừa khấp
+ Thượng quan	+ Tứ bạch	+ Đầu lâm khấp
+ Hàm yến	+ Bản thần	+ Liêm tuyền
+ Đại nghênh		

Huyệt toàn thân:

+ Tỳ du, Vị du, Túc tam lý, Tam âm giao, Hành gian, Thái xung, Thận du, Quan nguyên, Khí hải.

Chú ý: Người hành nghề lựa chọn số lượng huyệt, phương huyệt theo phác đồ huyệt trên hoặc chọn huyệt, phương huyệt khác phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Các bước thực hiện

Sử dụng chỉ liền kim để cấy chỉ xuyên huyệt.

Bước 1: Vệ sinh da vùng mặt cho người bệnh.

Bước 2: Sử dụng thuốc tê có dạng bào chế phù hợp với vùng thực hiện thủ thuật.

Chờ thời gian thuốc tê có tác dụng, sau đó làm sạch vùng thuốc tê.

Bước 3: Rửa tay sạch, đeo khẩu trang, đi găng tay vô trùng.

Bước 4: Tiêm tê hoặc dùng phương pháp vô cảm khác vùng cấy chỉ. Bước 5: Xác định huyệt và sát trùng vùng huyệt cấy chỉ bằng cồn i ốt. Đối với huyệt vùng mặt, sử dụng chỉ liền kim.

Đối với huyệt toàn thân, có thể sử dụng chỉ liền kim hoặc chỉ tự tiêu. Trường hợp sử dụng chỉ tự tiêu, thực hiện theo quy trình kỹ thuật cấy chỉ điều trị.

Bước 6: Châm kim nhanh qua da và đưa kim từ từ vào huyệt.

Tùy vị trí người hành nghề có thể lựa chọn huyệt trong phác đồ huyệt để cấy chỉ xuyên huyệt.

Nguyên tắc:

Cấy chỉ vào lớp mô mềm dưới da, dưới lớp hạ bì.

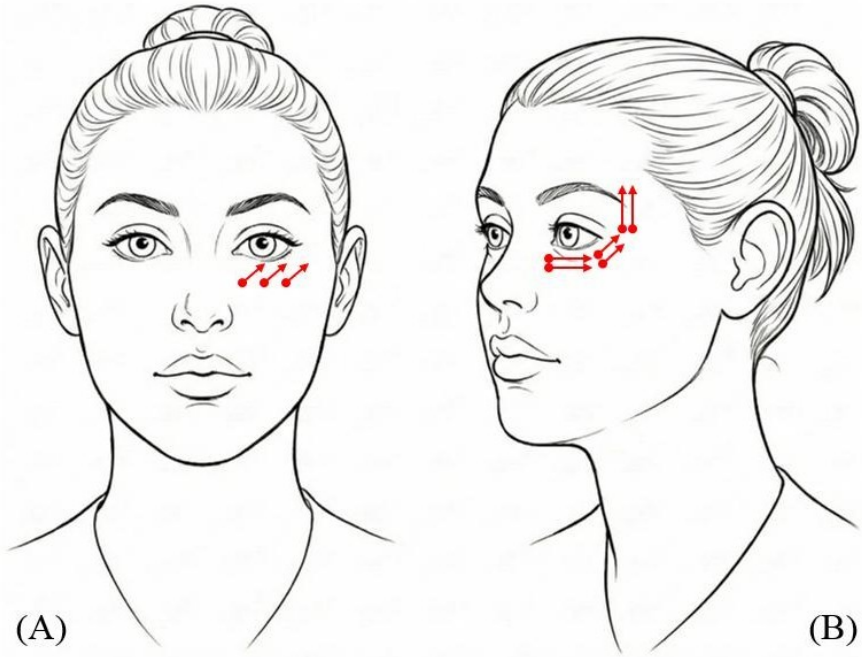
Thận trọng khi cấy chỉ vào vùng bó mạch, thần kinh.

Đúng trục vận động sinh lý của khuôn mặt.

Vùng dưới mắt:

Cấy 1 chỉ dưới huyệt Thừa khấp 0,5 cm hướng đến khóe mắt ngoài, cấy thêm 2 chỉ song song vào bên trái và bên phải của đường này, cách nhau 1 cm (mục A hình 1).

Cấy 1 chỉ ngang qua huyệt Thừa khấp, cấy 1 chỉ nối tiếp qua huyệt Đồng tử liêu theo hướng ra ngoài và 1 chỉ nối tiếp hướng thẳng đứng bên ngoài mắt. Cấy thêm 3 chỉ song song 3 đường trên (mục B hình 1).



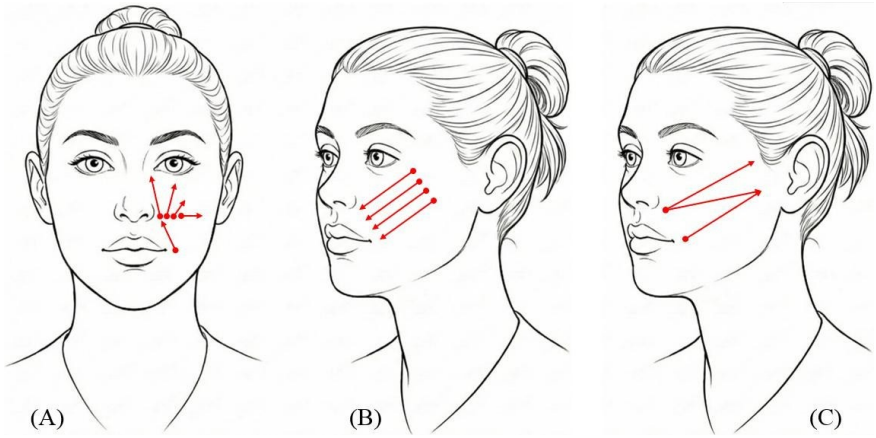
Hình 1: Cấy chỉ vùng dưới mắt

Vùng rãnh mũi má:

Cấy 1 chỉ dọc theo rãnh mũi má từ huyệt Địa thương đến Nghinh hương. Cấy 1 chỉ từ huyệt Nghinh hương hướng đến Tình minh, 1 chỉ cách huyệt Nghinh hương 0,5 cm ra ngoài hướng đến Tứ bạch, 1 chỉ cách huyệt Nghinh hương 1 cm ra ngoài hướng đến Cự liêu và 1 chỉ cách huyệt Nghinh hương 1,5 cm ra ngoài hướng đến Quyền liêu (mục A hình 2).

Cấy 1 chỉ từ điểm khóe mắt ngoài xuống dưới 1 cm và ra ngoài 2 cm hướng đến huyệt Nghinh hương, thêm 3 chỉ song song đường này với khoảng cách 1 cm hướng từ trên xuống dưới (mục B hình 2).

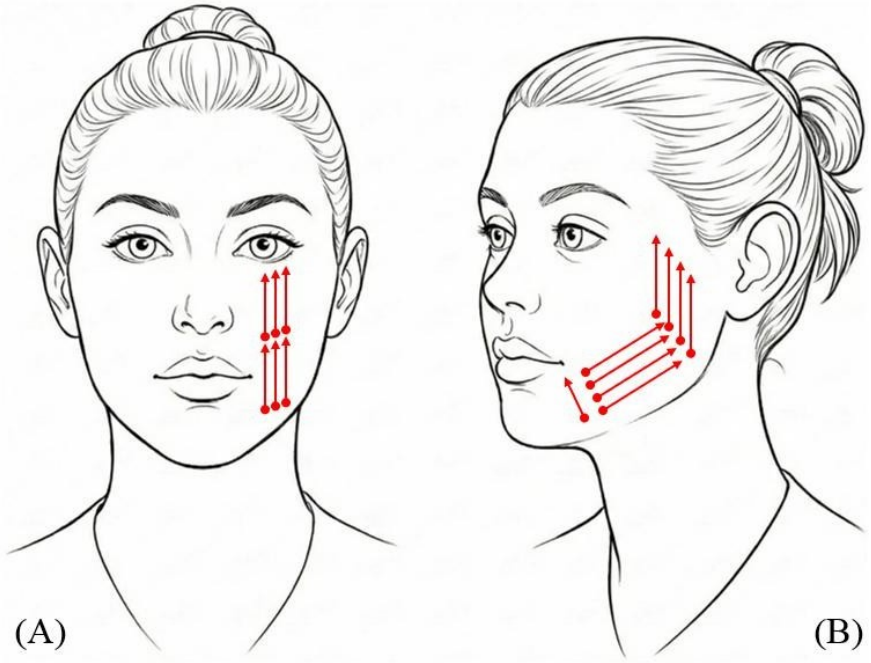
Cấy 1 chỉ từ huyệt Địa thương đến Hạ quan, 1 chỉ từ huyệt Nghinh hương đến Hạ quan và 1 chỉ từ huyệt Nghinh hương đến Thượng quan (mục C hình 2).



Hình 2. Cấy chỉ vùng rãnh mũi má

Vùng giữa và dưới của khuôn mặt:

Cấy 1 chỉ từ huyệt Đại nghênh hướng đến Cự liêu và 1 chỉ từ huyệt Cự liêu hướng đến Tứ bạch. Thêm 4 chỉ song song với 2 đường này với khoảng cách 0,5 - 1 cm từ dưới hướng lên trên (mục A hình 3).



Hình 3. Cấy chỉ vùng giữa, dưới khuôn mặt và vùng dưới hàm

Vùng dưới hàm:

Cấy 1 chỉ từ huyệt Đại nghênh đến Giáp xa, 1 chỉ từ huyệt Giáp xa đến Hạ quan, thêm 3 cặp chỉ song song với 2 đường này với khoảng cách 1 cm.

Cấy 1 chỉ dọc theo nếp nhăn từ dưới cằm hướng lên khóe miệng (Marionette line) (mục B hình 3).

Bước 7: Nhẹ nhàng rút kim ra, chỉ đã nằm lại trong huyệt. Sát trùng lại vùng huyệt vừa cấy chỉ bằng cồn i ốt, cồn sát trùng và nước muối sinh lý. Dán băng vô trùng lên huyệt vừa cấy chỉ. Chườm đá lạnh tại vùng cấy chỉ trong 10 phút để giảm tình trạng phù nề và bầm tím.

Bước 8: Thu dọn dụng cụ, rửa tay và theo dõi người bệnh.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bác sĩ hướng dẫn chăm sóc sau khi thực hiện cấy chỉ nâng cơ vùng mặt. Trong vòng 2 tuần đầu, người bệnh không cử động quá mức hoặc mạnh các cơ quanh miệng như ngáp, cười, hát, nhai, cũng như không được mát xa mặt. Người bệnh được khuyến khích ngủ ở tư thế nằm ngửa.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Người bệnh cần tái khám sau 2 tuần, 4 tuần và 8 tuần hoặc khi có dấu hiệu bất thường, có thể cấy thêm chỉ để cân chỉnh lại nếu cần thiết, không trùng vị trí đã cấy.

Tùy vào thời gian tự tiêu của chỉ, có thể tiến hành thực hiện liệu trình tiếp theo.

Tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

Sau cấy chỉ vẫn có thể tiếp tục điều trị bằng châm cứu nếu có bệnh lý khác.

Phác đồ huyệt châm cứu không trùng với huyệt đã cấy chỉ.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Phản vệ: Xử trí phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế.

Ngộ độc thuốc tê toàn thân: ngừng thuốc, gọi hỗ trợ, bảo đảm đường thở và oxy hóa, lấy bộ cấp cứu LAST và nhũ tương lipid 20%; xử trí theo phác đồ bệnh viện, đối chiếu bảng kiểm ASRA 2020. Không dùng trích dẫn ASRA 2019 làm hướng dẫn độc lập.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu sau cấy chỉ: Dùng bông khô vô khuẩn ấn cầm máu tại chỗ, không day.

Đau sưng nơi cấy chỉ: chườm lạnh, dùng thuốc chống viêm giảm phù nề hoặc kháng sinh (nếu cần).

Biến chứng muộn

- Đầu chỉ catgut lồi trên mặt da, có thể kèm nốt xơ cứng (u chỉ catgut):

Đầu chỉ lộ hoặc nghi nhiễm trùng: che phủ sạch, bác sĩ đánh giá và xử trí vô khuẩn theo tình trạng; không tự đẩy đoạn chỉ lộ trở lại dưới da. Hội chẩn khi không thể lấy an toàn.

+ Nốt xơ cứng: có thể sử dụng thuốc corticoid bôi tại chỗ (betamethasone, …), dùng thuốc kháng viêm, giảm đau đường uống khi người bệnh đau nhiều; theo dõi người bệnh.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

04 Cấy chỉ nâng cơ vùng cơ thể trừ mặt

Mã đề xuất QT YHCT 04 Phiên bản trình thẩm định 1.0

Dự thảo chờ xác nhận danh mục và thời điểm áp dụng theo QĐ2149; chưa xác nhận đủ điều kiện triển khai tại bệnh viện năm 2026.

1 Đại cương

Cấy chỉ là phương pháp châm cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, được tiến hành bằng cách đưa chỉ tự tiêu vào huyệt để phòng và chữa bệnh.

Theo y học cổ truyền trong quá trình phát triển đến giai đoạn thiên quý suy thì công năng của ngũ tạng suy giảm, cơ giảm trọng lượng và nhẽo, cùng với cân của cơ yếu, Thận suy giảm, tỳ vị kém điều hòa khí huyết làm cho da nhăn và tóc bạc. Khí huyết hư không nuôi dưỡng được da và cơ cũng làm da cơ trùng, nhẽo và chảy xệ.

Cấy chỉ có tác dụng bổ Can Thận, kiện Tỳ Vị, điều hòa khí huyết và kinh mạch ở vùng cơ thể. Cấy chỉ nâng cơ vùng cơ thể là thủ thuật đưa các đoạn chỉ tự tiêu bằng kim hoặc ống dẫn chuyên dụng vào dưới da và/hoặc lớp dưới hạ bì hoặc trung gian giữa lớp bì và cơ theo hướng chuyển động sinh lý của cơ hoặc phác đồ huyệt điều trị nhằm:

Tạo kích thích sinh học có chủ đích giúp cải thiện đàn hồi da theo thời gian.

Tạo tác động cơ học hỗ trợ tạm thời cho mô mềm, góp phần cải thiện trương lực cơ mức độ nhẹ và vừa.

Tóm lại cấy chỉ nâng cơ có tác dụng tạo lớp lưới nâng đỡ cơ chảy xệ, kích thích sản sinh ra các sợi collagen kết nối các tế bào da lại làm săn chắc da, tăng protein, hydratcarbon và tăng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ, đồng thời kích thích liên tục ở huyệt vị cải thiện tuần hoàn máu cho vùng cấy chỉ làm tăng trương lực các sợi cơ.

2 Chỉ định

Nhược cơ (Nuy chứng);

Bệnh nhão da người già;

Béo phì do thừa calo; Béo phì khu trú;

Tình trạng thừa da và thừa mô dưới da;

Lão suy do tuổi già;

Loạn dưỡng cơ;

Các bệnh cơ khác.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Dị ứng với loại chỉ được chỉ định cấy.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, mắc bệnh lý tâm thần.

Da vùng cấy chỉ bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng cấy chỉ.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Sa trễ nặng, tổn thương mô tuyến.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và có chứng chỉ hoặc chứng nhận Cấy chỉ nâng cơ vùng cơ thể chuyên ngành y học cổ truyền do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp hoặc được chuyển giao kỹ thuật và được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép bằng văn bản.

Nhân lực hỗ trợ:

Điều dưỡng đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng chạy ngoài.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

Thuốc có tác dụng gây tê (lidocaine, ...) hoặc thuốc theo hướng dẫn chuyên môn hoặc các phương pháp vô cảm khác.

Bác sĩ ghi loại, nồng độ, tổng thể tích và tổng liều thuốc tê; đối chiếu giới hạn theo cân nặng, bệnh nền, đường dùng và nhãn thuốc. Chuẩn bị phương án xử trí ngộ độc thuốc tê, không dùng thời gian chờ hay liều chung cho mọi chế phẩm.

5.3 Vật tư

Chỉ liền kim đảm bảo vô trùng.

Kim cấy chỉ và chỉ tự tiêu; hoặc đầu kim lấy thuốc, kim đẩy chỉ và chỉ tự tiêu.

Bông, cồn sát trùng và cồn i ốt.

Gạc vô trùng, băng dính hoặc băng vô trùng.

Săng vô khuẩn có lỗ và không có lỗ.

Xà phòng, nước sạch và dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Găng tay vô khuẩn, găng tay y tế, khẩu trang y tế, mũ trùm đầu y tế.

Dung dịch làm sạch da phù hợp vùng cơ thể được can thiệp.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ đựng bông vô khuẩn.

Bộ dụng cụ đo huyết áp.

Panh có mấu, kéo.

Khay đựng dụng cụ, kẹp không mấu, kẹp đầu nhọn.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được cấy chỉ.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian chờ thuốc tê theo loại và dạng bào chế được lựa chọn; không áp một thời gian cố định cho mọi phương pháp.

Thời gian thực hiện: 20 - 30 phút/ lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng vô khuẩn theo quy định.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, phác đồ huyệt, vị trí cấy chỉ, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Lựa chọn phác đồ huyệt:

Vùng cổ:

+ Liêm tuyền (định hướng, thận trọng).

+ Nhân nghinh (định hướng, không cấy trực tiếp sâu).

+ Phù đột.

+ Thiên đột (định hướng).

+ Phong trì (kết hợp phía sau cổ).

Vùng ngực:

+ Đản trung + Khí hộ

+ Khí xung + Nhũ căn

+ Thiên khê + Thần phong

Vùng bụng:

+ Trung quản + Hạ quản

+ Khí hải + Quan nguyên

+ Thiên khu + Đại hoành

+ Phục kết + Khí xung

+ Hoành cốt

Vùng đùi

- Huyệt tại chỗ vùng đùi trước - trong - ngoài:

+ Phong thị + Huyết hải

+ Lương khâu + Âm lăng tuyền

+Dương lăng tuyền + Phục thố

+ Tỳ quan

Huyệt vùng đùi sau:

+ Thừa phù + Ân môn

Vùng bắp tay (cánh tay trên)

Huyệt mặt ngoài - sau bắp tay:

+ Kiên ngung + Kiên liêu

+ Thủ tam lý + Ngoại quan

Huyệt mặt trong bắp tay:

+ Thiên phủ + Hiệp bạch

Huyệt toàn thân hỗ trợ (có thể phối hợp):

+ Túc tam lý + Phong long

+ Tam âm giao + Âm lăng tuyền

+ Thái xung + Chương môn

+ Tỳ du + Vị du

+ Đại trường du

Chú ý: Người hành nghề lựa chọn số lượng huyệt, phương huyệt theo phác đồ huyệt trên hoặc chọn huyệt, phương huyệt khác phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Các bước thực hiện:

Sử dụng chỉ liền kim để cấy chỉ xuyên huyệt. Bước 1: Vệ sinh da vùng cấy chỉ cho người bệnh.

Bước 2: Sử dụng thuốc tê có dạng bào chế phù hợp với vùng thực hiện thủ thuật.

Chờ thời gian thuốc tê có tác dụng, sau đó làm sạch vùng thuốc tê.

Bước 3: Rửa tay sạch, đeo khẩu trang, đi găng tay vô trùng.

Bước 4: Tiêm tê hoặc châm tê hoặc sử dụng phương pháp vô cảm vùng cấy chỉ.

Bước 5: Xác định huyệt và sát trùng vùng huyệt cấy chỉ.

Đối với các huyệt không thực hiện kỹ thuật xuyên huyệt, có thể sử dụng chỉ liền kim hoặc chỉ tự tiêu. Trường hợp sử dụng chỉ tự tiêu, thực hiện theo quy trình kỹ thuật cấy chỉ điều trị.

Bước 6: Châm kim nhanh qua da và đưa chỉ từ từ vào huyệt.

Tùy vị trí người hành nghề có thể lựa chọn huyệt trong phác đồ huyệt để cấy chỉ xuyên huyệt.

Lưu ý:

Không cấy sâu, không đâm thẳng tại các vùng có tạng đặc và rỗng: gan, dạ dày, ruột, lách, thận, bàng quang.

Khi cấy vùng ngực - bụng:

+ Chỉ cấy lớp cơ nông hoặc mô dưới da.

+ Tránh hướng kim vuông góc đi sâu về phía khoang tạng.

VÙNG CỔ

Nguyên tắc chung:

Cấy nông, lớp mô dưới da

Hướng kim song song bề mặt da cổ

Tránh đường giữa cổ và vùng bó mạch cảnh

Cụ thể theo vùng:

Vùng cổ trước (submental – anterior neck)

Cấy chỉ theo hướng ngang hoặc chếch nhẹ lên trên, song song các nếp gấp da cổ. Có thể cấy nhiều sợi song song, khoảng cách 1 - 1,5 cm.

Không hướng kim vào đường giữa cổ.

Vùng cổ bên

Cấy chỉ theo hướng chếch lên trên và ra sau, theo trục da cổ. Tránh vùng Nhân nghinh – bó mạch cảnh.

Chỉ cấy nông, không xuyên sâu.

Vùng cổ sau (kết hợp)

Phong trì cấy chỉ hướng chếch xuống dưới theo trục cơ nông vùng gáy Phối hợp nhằm cải thiện trương lực toàn vùng cổ

VÙNG NGỰC

Nguyên tắc:

Cấy chỉ tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông, theo trục giải phẫu và sinh lý vùng ngực.

Hướng cấy chếch lên trên hoặc chếch ra ngoài, tránh hướng kim vuông góc và tránh đi sâu vào mô tuyến vú.

Mũi kim chếch khoảng 30 - 45 độ, không cấy sâu.

Cụ thể:

Đản trung cấy chỉ hướng chếch lên trên về phía Khí hộ, dừng ở lớp mô dưới da vùng dưới xương đòn.

Nhũ căn cấy chỉ hướng chếch lên trên về phía Đản trung hoặc Khí hộ, không đi sâu vào mô tuyến vú.

Nhũ căn cấy chỉ hướng chếch lên trên và ra ngoài về phía Thiên khê.

Khí hộ cấy chỉ hướng lên vùng dưới xương đòn, theo trục kinh Phế ở lớp mô nông.

Lưu ý:

Không cấy sâu, không hướng kim vào khoang ngực.

Kỹ thuật cấy chỉ vùng ngực chỉ áp dụng tại lớp mô dưới da và cơ nông, không nhằm can thiệp mô tuyến vú, không thay thế các phương pháp điều trị ngoại khoa.

VÙNG BỤNG TRÊN (THƯỢNG VỊ)

Cấy chỉ theo hướng ngang hoặc chếch lên trên, tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông, theo trục cơ thẳng bụng.

Trung quản cấy chỉ hướng chếch sang hai bên về phía Thiên khu.

VÙNG QUANH RỐN

Cấy chỉ theo hướng chéo hoặc vòng cung quanh rốn, tránh xuyên trực tiếp qua rốn.

Khí hải cấy chỉ hướng chếch sang hai bên về phía Thiên khu.

Thiên khu cấy chỉ hướng nông về phía Đại hoành.

VÙNG BỤNG DƯỚI (HẠ VỊ)

Cấy chỉ theo hướng chếch lên trên, tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông, tạo lực nâng hướng về rốn.

Quan nguyên cấy chỉ hướng lên trên về phía Khí hải.

Quan nguyên cấy chỉ hướng chếch sang hai bên về phía Phục kết.

VÙNG HÔNG – EO

Cấy chỉ theo hướng chếch lên trên và vào trong, theo trục cơ chéo bụng.

Đại hoành cấy chỉ hướng về Phục kết.

Phục kết cấy chỉ hướng chếch xuống dưới về phía Khí xung.

VÙNG ĐÙI

Nguyên tắc chung

Cấy chỉ tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông, không cấy sâu vào bó mạch thần kinh đùi.

Hướng kim theo trục cơ, chếch nhẹ (khoảng 30 - 45°), tránh châm vuông góc.

Tránh vùng tam giác đùi, vùng mạch đùi, tĩnh mạch hiển lớn.

Cụ thể

Vùng đùi trước

Cấy chỉ theo hướng dọc hoặc chếch lên trên, song song trục cơ tứ đầu đùi. Có thể cấy từ: Huyết hải hướng lên trên hoặc ra ngoài

Kim đi nông, không xuyên sâu.

Vùng đùi ngoài

Cấy chỉ tại Phong thị theo hướng chếch lên trên hoặc ra sau, theo trục cơ đùi ngoài. Tránh vùng gần bó mạch đùi.

Vùng đùi trong

Cấy chỉ thận trọng, cấy nông, tránh tĩnh mạch hiển lớn. Hướng kim chếch lên trên, không hướng vào vùng bẹn.

VÙNG BẮP TAY

Nguyên tắc chung

Cấy chỉ tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông vùng cánh tay.

Hướng kim theo trục cơ cánh tay, chếch nhẹ, tránh bó mạch và thần kinh cánh tay.

Tránh rãnh thần kinh quay phía sau cánh tay.

Cụ thể

Vùng bắp tay trước

Cấy chỉ theo hướng dọc hoặc chếch lên trên, song song trục cơ nhị đầu cánh tay. Có thể cấy tại: Thủ tam lý hướng lên trên

Kim đi nông, không xuyên sâu.

Vùng bắp tay sau

Cấy chỉ thận trọng, tránh rãnh thần kinh quay.

Hướng kim chếch lên trên hoặc ra ngoài, theo trục cơ tam đầu. Không cấy sâu, không hướng kim vuông góc.

Lưu ý: Kỹ thuật cấy chỉ vùng đùi và bắp tay được thực hiện tại lớp mô dưới da hoặc cơ nông, theo trục cơ, không can thiệp bó mạch thần kinh lớn, nhằm hỗ trợ cải thiện trương lực mô mềm mức độ nhẹ và vừa.

Bước 7: Nhẹ nhàng rút kim ra, chỉ đã nằm lại trong huyệt. Sát trùng lại vùng huyệt vừa cấy chỉ bằng bông vô khuẩn. Dán băng vô trùng lên huyệt vừa cấy chỉ.

Bước 8: Thu dọn dụng cụ, rửa tay và theo dõi người bệnh.

Kết thúc quy trình:

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị:

Người bệnh cần tái khám sau 2 tuần, 4 tuần và 8 tuần để bác sĩ cân chỉnh lại nếu cần thiết, không trùng vị trí đã cấy.

Thời gian phân hủy phụ thuộc loại chỉ tự tiêu được sử dụng theo công bố của nhà sản xuất mà bác sĩ có thể tiến hành thực hiện liệu trình tiếp theo.

Tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

Sau cấy chỉ vẫn có thể tiếp tục điều trị bằng châm cứu nếu có bệnh lý khác (Phác đồ huyệt châm cứu không trùng với huyệt đã cấy chỉ)

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Phản vệ: Xử trí phản vệ theo phác đồ.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Với người gầy, thành bụng mỏng, người cao tuổi: khi thực hiện thủ thuật cần giảm độ sâu, giảm lực tay. Nếu người bệnh có đau chói sâu, tức lan, khó thở, buồn nôn phải dừng ngay thủ thuật, xử lý rút kim nhanh và đánh giá lại vị trí.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu sau khi rút kim: Dùng bông khô vô khuẩn ấn cầm máu tại chỗ, không day.

Đau sưng nơi cấy chỉ: chườm lạnh, dùng thuốc chống viêm giảm phù nề hoặc kháng sinh (nếu cần).

Biến chứng muộn:

Đầu chỉ catgut lồi trên mặt da, có thể kèm nốt xơ cứng (u chỉ catgut):

Đầu chỉ lộ hoặc nghi nhiễm trùng: che phủ sạch, bác sĩ đánh giá và xử trí vô khuẩn theo tình trạng; không tự đẩy đoạn chỉ lộ trở lại dưới da. Hội chẩn khi không thể lấy an toàn.

+ Nốt xơ cứng: có thể sử dụng thuốc corticoid bôi tại chỗ (betamethasone, …), dùng thuốc kháng viêm, giảm đau đường uống khi người bệnh đau nhiều; theo dõi người bệnh.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y Tế (2013), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.

Bộ Y Tế (2020), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền. Ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Nguyễn Nhược Kim, Đỗ Tất Lợi (2007), Châm cứu học.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

05 Chườm thuốc cổ truyền

Mã đề xuất QT YHCT 05 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Chườm thuốc cổ truyền là phương pháp dùng các vị thuốc cổ truyền làm nóng, được bọc lại trong túi chườm để chườm lên vị trí bệnh nhằm mục đích điều trị một số chứng bệnh thường gặp như: cảm mạo phong hàn, co cơ do lạnh, đau xương khớp do lạnh, ...

2 Chỉ định

Các trường hợp cảm mạo phong hàn.

Đau bụng do lạnh, co cơ do lạnh, đau dây thần kinh ngoại biên do lạnh.

Các chứng đau cơ xương khớp thể hàn: Thoái hoá cột sống, thoái hóa khớp, đau lưng cấp, đau cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm cột sống viêm quanh khớp vai, …

Mày đay, dị ứng do lạnh.

3 Chống chỉ định

Người bệnh mất, giảm cảm giác da vùng chườm.

Vùng da tổn thương: vết thương hở, sưng nề sau chấn thương, đang có xuất huyết dưới da hoặc xuất huyết nội tạng, mụn nhọt, chàm, ...

Sốt cao, nhiễm trùng, nhiễm độc.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu.

Đau bụng có dấu hiệu ngoại khoa.

4 Thận trọng

Người say rượu, người có bệnh lý tâm thần, …

Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

- Bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền, lương y, kỹ thuật viên phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Các thuốc cổ truyền phù hợp với bệnh lý của người bệnh và được làm nóng ở nhiệt độ phù hợp, cho vào túi chườm hoặc bọc vào khăn.

Thuốc điều trị bỏng (panthenol, ...).

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Khăn khô thấm nước (Khăn vải).

Túi đựng thuốc chườm.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ làm nóng thuốc: bếp, lò vi sóng, …

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật. Người bệnh được nằm, ngồi ở tư thế thoải mái, phù hợp với điều trị, mặc quần áo rộng rãi để dễ bộc lộ vị trí chườm, tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Bệnh án chẩn đoán hoặc sổ khám bệnh chẩn đoán, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và phiếu chỉ định của bác sĩ.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ tối thiểu 15 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1: Làm nóng thuốc với nhiệt độ phù hợp với vùng cơ thể chườm.

Bước 2: Sát khuẩn tay.

Bước 3: Bộc lộ vùng chườm.

Bước 4: Đặt thuốc chườm lên vùng trị liệu, sau đó di chuyển thuốc chườm nhẹ nhàng lên vùng da cần trị liệu và cần xác nhận với người bệnh về cảm nhận nhiệt độ khi đặt túi chườm.

Bước 5: Kết thúc chườm.

Lấy thuốc chườm ra, lau sạch vùng trị liệu.

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

1 ngày có thể chườm 1 hoặc nhiều lần (theo chỉ định của bác sĩ), 1 liệu trình từ 5 - 7 ngày, có thể thực hiện nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện thủ thuật.

Người bệnh có hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi: dừng chườm, nghỉ ngơi, bù nước điện giải (nếu cần).

Rát da, đỏ da, bỏng: ngừng chườm điều trị theo phác đồ điều trị bỏng của Bộ Y tế.

Phản ứng phản vệ: xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ của bộ Y tế.

Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng

thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2020). Quyết định số 5480/QĐ - BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

06 Cứu ngải

Mã đề xuất QT YHCT 06 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Cứu là phương pháp dùng sức nóng từ mồi ngải hoặc điếu ngải tác động lên huyệt để phòng và điều trị bệnh.

Cứu bao gồm cứu trực tiếp, cứu gián tiếp. Cứu trực tiếp là dùng mồi ngải đặt vào huyệt rồi đốt, hoặc dùng điếu ngải hơ trực tiếp trên huyệt hoặc qua hộp cứu ngải. Cứu gián tiếp bao gồm cứu cách gừng, cứu cách tỏi, cứu cách muối.

2 Chỉ định

Bệnh lý có nguyên nhân hàn.

Các bệnh mạn tính, thể trạng hư nhược.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu.

Các bệnh có chỉ định ngoại khoa.

Các trường hợp bệnh lý có nguyên nhân thực nhiệt; hư nhiệt gây sốt.

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Có khối u tại chỗ, viêm da, tổn thương da.

Người bệnh đang trong trạng thái kích động, kích thích, sợ hãi.

4 Thận trọng

Vùng da giảm cảm giác, người sử dụng chất kích thích (uống bia, rượu, …), bệnh lý tâm thần, …

Cứu ở các vùng có nhiều gân, da sát xương, vùng mặt, vùng có tóc, ...

Khi đói, cơ thể quá suy nhược.

Theo dõi liên tục nguồn lửa và nhiệt, bảo đảm thông khí, tránh oxy và chất dễ cháy; để chất sát khuẩn khô hoàn toàn. Không rời người bệnh khi còn ngải hoặc vật nóng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, Y sỹ, Lương y, kỹ thuật viên phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật cứu ngải thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Thuốc trị bỏng Panthenol.

Thuốc cổ truyền với dạng bào chế phù hợp.

5.3 Vật tư

Lửa (diêm, bật lửa, ...).

Bông, gạc.

Gừng đã thái dày 2-3mm, tỏi, muối (sử dụng khi cứu gián tiếp).

Điếu ngải hoặc mồi ngải.

Dao loại nhỏ, sắc.

Khay đựng dụng cụ.

Hộp cứu ngải (khi cứu trực tiếp có dùng hộp cứu ngải).

Khay đựng tàn ngải hoặc que gạt tàn.

5.4 Trang thiết bị

Bố trí giường hoặc ghế thủ thuật và phương tiện theo dõi, gọi hỗ trợ phù hợp kỹ thuật.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng.

Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật. Người bệnh được nằm, ngồi ở tư thế thoải mái, phù hợp với điều trị, mặc quần áo rộng rãi để dễ bộc lộ vị trí cứu, tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Bệnh án chẩn đoán hoặc sổ khám bệnh chẩn đoán, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và phiếu chỉ định của bác sĩ.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ tối thiểu 15 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật đảm bảo thông khí.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

- Tùy bệnh tật và huyệt cần cứu mà chọn cách cứu trực tiếp hay gián tiếp.

Bước 1:

Sát khuẩn tay.

Xác định đúng huyệt và vùng cần cứu.

Bước 2:

Cứu trực tiếp:

Nếu Dùng mồi ngải: đặt mồi ngải vào huyệt rồi đốt, khi mồi ngải cháy được 1/2 người bệnh có cảm giác nóng nơi cứu thì nhấc mồi ngải ra sau đó thay bằng mồi ngải khác.

Nếu dùng điếu ngải: đốt điếu ngải, hơ điếu ngải trên vùng huyệt theo phương pháp mổ cò, xoay vòng, …

Cứu gián tiếp

Dùng lát gừng, tỏi, muối hoặc thuốc cổ truyền với dạng bào chế phù hợp, ... lót vào giữa da và mồi ngải.

Bước 3: Đốt mồi ngải để cứu.

Trong khi cứu, nếu người bệnh thấy nóng nhiều thì nhấc lát gừng, tỏi lên để giảm độ nóng sau đó tiếp tục cứu. Cũng có thể lót thêm một lát gừng, tỏi khác để giảm sức nóng của mồi ngải.

Khi nào da vùng huyệt ấm lên và có quầng đỏ thì chuyển sang cứu huyệt khác.

Bước 4. Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi thực hiện thủ thuật

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị: mỗi ngày cứu 1 hay nhiều lần (tùy theo chỉ định của bác sĩ); 1 liệu trình từ 5 - 7 ngày, có thể thực hiện nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến khi thực hiện thủ thuật.

Bỏng:

Xử trí: dừng cứu, xử trí theo phác đồ trị bỏng của Bộ Y tế.

Đề phòng: Thường xuyên làm sạch tàn trên điếu ngải, kiểm tra độ ấm của da vùng cứu, tránh giữ điếu ngải tại một vị trí quá lâu.

Cháy:

Xử trí: nhanh chóng dập tắt nguồn phát lửa.

Đề phòng: Đảm bảo không đọng tàn ngải trên ngọn điếu ngải.

Người bệnh có hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi: dừng cứu, nghỉ ngơi.

Phản ứng phản vệ: xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế

Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2013). Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về danh mục hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành châm cứu.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

07 Cứu ngải trẻ nhi

Mã đề xuất QT YHCT 07 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Cứu là phương pháp dùng sức nóng từ mồi ngải hoặc điếu ngải tác động lên huyệt để phòng và điều trị bệnh.

Cứu bao gồm cứu trực tiếp, cứu gián tiếp. Cứu trực tiếp là dùng mồi ngải đặt vào huyệt rồi đốt, hoặc dùng điếu ngải hơ trực tiếp trên huyệt hoặc qua hộp cứu ngải. Cứu gián tiếp bao gồm cứu cách gừng, cứu cách tỏi, cứu cách muối.

Ở trẻ nhỏ, để đảm bảo an toàn thường chỉ sử dụng phương thức cứu trực tiếp, sử dụng hơ điếu ngải hoặc qua hộp cứu ngải. Cứu gián tiếp có thể áp dụng ở trẻ trên 15 tuổi.

2 Chỉ định

Trẻ mắc bệnh lý có nguyên nhân hàn;

Các bệnh mạn tính, thể trạng hư nhược.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu;

Các bệnh có chỉ định ngoại khoa;

Các trường hợp bệnh lý có nguyên nhân thực nhiệt; hư nhiệt gây sốt;

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da;

Có khối u tại chỗ, viêm da, tổn thương da;

Người bệnh đang trong trạng thái kích động, kích thích, sợ hãi;

Trẻ dưới 12 tháng tuổi.

4 Thận trọng

Khi cứu ở vùng có nhiều gân, da sát xương, vùng mặt, vùng có tóc.

Cứu ở những vùng da có rối loạn hoặc giảm cảm giác.

Ngay sau khi ăn no, khi đói, cơ thể quá suy nhược.

Theo dõi liên tục nguồn lửa và nhiệt, bảo đảm thông khí, tránh oxy và chất dễ cháy; để chất sát khuẩn khô hoàn toàn. Không rời người bệnh khi còn ngải hoặc vật nóng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp

Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên y đủ điều kiện thực hiện thủ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật cứu ngải thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Lương y đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh trên 15 tuổi.

Nhân lực hỗ trợ

Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Thuốc trị bỏng Panthenol.

5.3 Vật tư

Điếu ngải hoặc mồi ngải.

Gừng đã thái dày 2-3mm, hoặc tỏi, muối (sử dụng khi cứu gián tiếp).

Diêm, bật lửa, ...

Khay đựng tàn, que gạt tàn.

Khay đựng dụng cụ y tế.

Dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng rửa tay, khăn lau tay.

Khẩu trang.

Hộp cứu ngải (khi cứu trực tiếp có dùng hộp cứu ngải).

5.4 Trang thiết bị

Bố trí giường hoặc ghế thủ thuật và phương tiện theo dõi, gọi hỗ trợ phù hợp kỹ thuật.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian cứu: 15-30 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1

Sát khuẩn tay.

Xác định đúng huyệt và vùng cần cứu.

Bước 2

Người phụ hỗ trợ giữ người bệnh và cố định vùng cơ thể chứa huyệt vị cần tiến hành kỹ thuật.

Người làm thủ thuật chính tiến hành thủ thuật theo một trong các cách sau:

a, Cứu trực tiếp

Kỹ thuật sử dụng điếu ngải:

+ Đốt cháy điếu ngải.

+ Người làm thủ thuật chính một tay dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt trên mặt da gần vùng huyệt, tay kia cầm điếu ngải: hơ điếu ngải cố định cách da vùng huyệt khoảng 1,5 - 2cm đưa từ xa vào gần và ngược lại, hoặc xoay điếu ngải theo đường xoáy từ trong ra ngoài, từ hẹp đến rộng.

+ Vừa hơ điếu ngải vừa dùng ngón tay áp lên da người bệnh kiểm tra độ ấm của da vùng huyệt mỗi khi điếu ngải ra xa.

+ Khi thấy da vùng huyệt ấm nóng hoặc người bệnh kêu nóng thì chuyển sang cứu huyệt khác, cách thức làm tương tự.

+ Người phụ tiến hành hỗ trợ dụng cụ và gạt bỏ tàn đã cháy của điếu ngải.

+ Lần lượt tiến hành luân phiên các huyệt (theo chỉ định công thức huyệt), mỗi huyệt không quá 2 phút và lặp lại cho đến khi đủ thời gian theo chỉ định của thầy thuốc.

Lưu ý: Khi điếu ngải cháy xuất hiện tàn, cần dùng que gạt tàn ngải vào khay, tránh để tàn ngải rơi lên da người bệnh, rơi xuống giường thủ thuật.

Kỹ thuật sử dụng hộp cứu ngải:

+ Đốt cháy điếu ngải.

+ Cố định hộp cứu ngải vào vị trí huyệt vị cần cứu.

+ Đặt điếu ngải chắc chắn vào vị trí đặt ngải của hộp, đảm bảo đúng khoảng cách từ đầu điếu ngải đến đáy hộp cứu ngải. Nếu người bệnh kêu nóng hoặc phản ứng khó chịu thì cần đưa ra xa thêm 0,5cm.

Kỹ thuật sử dụng mồi ngải đặt trên da (Chỉ áp dụng với người bệnh trên 15 tuổi).

+ Dùng mồi ngải đặt lên vị trí huyệt cần cứu. Đốt cháy mồi ngải.

+ Khi mồi ngải cháy được 1/3 đến 2/3, người bệnh có cảm giác nóng nơi cứu thì nhấc mồi ngải ra sau đó thay bằng mồi ngải khác. Sau khi cứu xong vị trí huyệt cứu thấy ấm và có quầng đỏ.

b, Kỹ thuật cứu gián tiếp (Chỉ áp dụng với trẻ trên 15 tuổi).

Dùng gừng, tỏi thái mỏng theo phần chuẩn bị 2–3 mm hoặc lớp vật liệu phù hợp; không dùng số 2–3 cm do không thống nhất trong bản nguồn. Khoa xác nhận vật liệu, độ dày và cách kiểm soát nhiệt trước áp dụng; chỉ áp dụng phương thức này cho trẻ trên 15 tuổi theo nguồn.

Đốt mồi ngải để cứu. Trong khi cứu, nếu người bệnh thấy nóng nhiều thì nhấc lát gừng, tỏi lên để giảm độ nóng sau đó tiếp tục cứu. Cũng có thể lót thêm một lát gừng, tỏi khác để giảm sức nóng của mồi ngải. Tùy theo bệnh mà chọn nguyên liệu là gừng, tỏi, hoặc muối để lót mồi ngải.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị:

Mỗi ngày cứu 1 - 2 lần. 3 - 30 lần/liệu trình.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật:

Bỏng:

Hay gặp ở người bệnh bị giảm hoặc mất cảm giác nông (đau và nóng - lạnh) dễ bị bỏng. Người bệnh thấy nóng rát sau khi cứu, trên mặt da vùng huyệt được cứu xuất hiện phỏng nước.

Xử trí: làm dịu vết thương, dùng thuốc trị bỏng và dán băng tránh nhiễm trùng.

Đề phòng: Thường xuyên làm sạch tàn trên điếu ngải, kiểm tra độ ấm của da vùng cứu, tránh giữ điếu ngải tại một vị trí quá lâu.

Cháy: Trẻ nhi giẫy giụa, do vô tình, hoặc do vướng vào quần áo, chăn đệm gây cháy.

Xử trí: nhanh chóng dập tắt nguồn phát lửa.

Đề phòng: Giữ ổn định người bệnh trong khi làm thủ thuât. Tránh làm người bệnh sợ hãi quá mức. Đảm bảo không đọng tàn ngải trên ngọn điếu ngải.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chưa ghi nhận trong mô tả nguồn; vẫn theo dõi và hướng dẫn báo bất thường.

Biến chứng muộn

Chưa ghi nhận trong mô tả nguồn; vẫn theo dõi và hướng dẫn báo bất thường.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013), Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học.

Bộ Y tế (2013), "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu".

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

08 Điện châm

Mã đề xuất QT YHCT 08 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Điện châm là phương pháp kết hợp giữa chữa bệnh bằng châm cứu của y học cổ truyền với chữa bệnh bằng dòng điện của y học hiện đại. Dùng dòng điện tần số thấp tác động lên các huyệt vị thông qua kim châm hoặc các điện cực nhỏ đặt lên da vùng huyệt để phòng và chữa bệnh.

Hiện nay thường sử dụng máy phát ra xung điện có tính ổn định, an toàn, điều chỉnh thao tác dễ dàng, đơn giản. Kích thích của dòng xung điện có tác dụng làm giảm đau, giảm viêm, kích thích hoạt động các cơ, các tổ chức, tăng cường dinh dưỡng các tổ chức, ...

2 Chỉ định

Bệnh lý cơ xương khớp: Hội chứng cánh tay cổ, vẹo cổ, đau vùng cổ gáy, đau lưng, Bệnh khớp (Viêm đa khớp, thoái hóa khớp, …), Bệnh cột sống, Các bệnh cơ, Các bệnh lý mô mềm, …

Bệnh lý Thần kinh, Tâm thần: Chứng liệt do các nguyên nhân (liệt do tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt, liệt các dây thần kinh ngoại biên, Bệnh dây thần kinh mặt, …); viêm đa dây, rễ, đám rối thần kinh, đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh liên sườn, bệnh dây thần kinh tam thoa, đau thần kinh sau zona, …; Hội chứng rối loạn Tíc, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn phân ly, rối loạn lo âu, trầm cảm; Chậm phát triển do các nguyên nhân, rối loạn phổ tự kỷ, …

Bệnh hệ tuần hoàn: Tăng huyết áp, huyết áp thấp, thiếu máu não cục bộ mạn tính, viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch, …

Bệnh lý hô hấp: viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, hen phế quản, viêm họng, …

Bệnh lý tiêu hóa: Hội chứng ruột kích thích, Hội chứng dạ dày - tá tràng, táo bón, bệnh lý đường mật, trĩ …

Bệnh lý sản phụ khoa: Viêm tắc tuyến vú, Đau và tình trạng khác liên quan đến cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ kinh nguyệt, …

Bệnh lý ngũ quan: chắp, lẹo, lác, các bệnh thần kinh thị giác, ù tai, giảm thính lực, …

Bệnh lý Tiết niệu, Nam khoa: di tinh, liệt dương, đái dầm, hội chứng bàng quang tăng hoạt, bí tiểu, sỏi tiết niệu, …

- Các bệnh lý khác: Rối loạn chức năng tiền đình, giảm đau do ung thư, giảm đau sau phẫu thuật, cai nghiện (rượu, ma túy, thuốc lá, games), …

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Người bệnh có rối loạn nhịp tim hoặc có đeo máy tạo nhịp.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: Bác sĩ, y sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, dùng riêng cho từng người bệnh.

Bông, cồn 70%.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Máy điện châm, pin, dây nối máy.

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu.

Ống nghe, dụng cụ đo huyết áp.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng, theo quy định.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 đến 30 phút/lần.

Trong đó:

+ Thời gian châm: 5 phút.

+ Thời gian lưu kim: 20 - 25 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1

Sát khuẩn tay, đeo găng tay.

Bước 2

Xác định và sát trùng da vùng huyệt.

Chọn kim có độ dài phù hợp với độ dày của cơ vùng định châm.

Bước 3: Châm kim vào huyệt theo các thì sau:

Thì 1: Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn và căng da vùng huyệt; Tay kia châm kim nhanh qua da vùng huyệt.

Thì 2: Đẩy kim từ từ theo huyệt đạo, kích thích kim cho đến khi đạt“Đắc khí” (Người bệnh có cảm giác căng, tức, nặng vừa phải, không đau ở vùng huyệt vừa châm kim, thầy thuốc cảm giác kim mút chặt tại vị trí huyệt), kỹ thuật đẩy kim và kích thích tùy thuộc phương pháp bổ tả mà thầy thuốc áp dụng cho từng người bệnh và từng huyệt cụ thể.

Bước 4: Kích thích huyệt bằng máy điện châm.

Nối cặp dây của máy điện châm với kim đã châm vào huyệt theo tần số bổ - tả của máy điện châm:

Trước nối hoặc tháo dây phải đưa cường độ về không và tắt phát; kiểm tra máy, dây, vị trí cặp điện cực và hướng dẫn thiết bị. Không dùng khi chưa đánh giá nguy cơ với máy tạo nhịp hoặc thiết bị cấy ghép.

Tần số (đặt tần số cố định): Tần số tả từ 5 -10Hz, Tần số bổ từ 1 -3Hz.

Điều chỉnh tần số bổ, tả theo phác đồ huyệt và tình trạng bệnh lý và giai đoạn bệnh của Người bệnh.

Cường độ: điều chỉnh tăng, giảm cường độ theo mức chịu đựng của người bệnh.

Bước 5. Đưa cường độ về không, tắt máy, tháo dây, kiểm tra đủ kim rồi rút kim và sát khuẩn da vùng huyệt.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Châm 1 - 2 lần/ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 1 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu khi rút kim: dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Gãy kim: Tắt máy điện châm, rút tất cả các kim còn lại. Nếu phần kim gãy còn trồi trên mặt da thì nhẹ nhàng dùng panh có mấu rút kim ra, nếu phần kim gãy nằm trong cơ thì cố định vùng huyệt có kim bị gãy, chuyển ngoại khoa xử trí.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

09 Điện châm trẻ nhi

Mã đề xuất QT YHCT 09 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Điện châm là phương pháp kết hợp giữa chữa bệnh bằng châm cứu của y học cổ truyền với chữa bệnh bằng dòng điện của y học hiện đại. Dùng dòng điện tần số thấp tác động lên các huyệt vị thông qua kim châm hoặc các điện cực nhỏ đặt lên da vùng huyệt để phòng và chữa bệnh.

Hiện nay thường sử dụng máy phát ra xung điện có tính ổn định, an toàn, điều chỉnh thao tác dễ dàng, đơn giản. Kích thích của dòng điện có tác dụng làm giảm đau, giảm viêm, kích thích hoạt động các cơ, các tổ chức, tăng cường dinh dưỡng các tổ chức, ...

Điện châm ở trẻ nhi thường sử dụng cường độ và tần số nhỏ hơn so với người lớn.

2 Chỉ định

Bệnh lý thần kinh, tâm thần: đau đầu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn phân ly, chậm phát triển do các nguyên nhân, rối loạn phổ tự kỷ, các rối loạn Tic và hội chứng Tourette, …; chứng liệt do các nguyên nhân (liệt do tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt, liệt các dây thần kinh ngoại biên, bệnh dây thần kinh mặt, …); viêm đa dây, rễ, đám rối thần kinh, đau dây thần kinh liên sườn, bệnh dây thần kinh tam thoa, …

Bệnh lý cơ xương khớp: vẹo cổ cấp, đau vùng cổ gáy, đau lưng, bệnh khớp (viêm khớp tự miễn, viêm khớp thiếu niên, …), bệnh cột sống, các bệnh cơ, các bệnh lý mô mềm, …

Bệnh lý hô hấp: viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, hen phế quản, viêm họng, viêm Amydal, …

Bệnh lý tiêu hóa: hội chứng ruột kích thích, hội chứng dạ dày - tá tràng, táo bón, đại tiện són phân, bệnh lý đường mật, sa trực tràng, …

Bệnh lý phụ khoa: đau và tình trạng khác liên quan đến cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ kinh nguyệt, …

Bệnh lý ngũ quan: chắp, lẹo, lác, các bệnh thần kinh thị giác, ù tai, giảm thính lực, …

Bệnh lý tiết niệu: đái dầm, bí tiểu, rối loạn tiểu tiện, …

Các bệnh lý khác: rối loạn chức năng tiền đình, giảm đau trong ung thư, giảm đau sau phẫu thuật, cai nghiện (games, thuốc lá, …), …

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu.

Các bệnh có chỉ định ngoại khoa

Da bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Người bệnh có rối loạn nhịp tim hoặc có đặt máy tạo nhịp

Người bệnh trong trạng thái kích thích, sợ hãi quá mức.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Có tiền sử động kinh.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Ngay sau khi ăn no, khi đói.

Người bệnh dưới 18 tháng tuổi.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ

Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim hào châm vô khuẩn dùng một lần, kích cỡ phù hợp.

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu, bông, cồn 70%.

Xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, khăn lau tay, khẩu trang.

5.4 Trang thiết bị

Máy điện châm.

Dây nối máy điện châm.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 - 30 phút/lần.

Trong đó:

+ Thời gian châm: 05 - 10 phút.

+ Tùy theo lứa tuổi, thời gian lưu kim từ 10 - 25 phút.

+ Trường hợp trẻ kêu khóc, quẫy đạp nhiều, có thể không lưu kim.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đặt người bệnh ở tư thế thoải mái nhất, phù hợp nhất; trẻ sợ hãi cần có người bế, giữ; bộc lộ vùng cần làm thủ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1

Sát khuẩn tay, đeo găng tay.

Bước 2

Xác định và sát khuẩn da vùng huyệt cần châm.

Lựa chọn kim có độ dài, kích cỡ phù hợp lứa tuổi của trẻ và vị trí huyệt.

Bước 3:

Tiến hành châm kim hào châm vào huyệt.

+ Người phụ hỗ trợ giữ người bệnh và cố định vùng cơ thể chứa huyệt vị cần tiến hành kỹ thuật.

+ Người làm chính tiến hành châm kim vào huyệt theo các thì sau:

Thì 1: Một tay dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn, căng da vùng huyệt; tay kia châm kim nhanh qua da vùng huyệt.

Thì 2. Đưa kim theo hướng và độ sâu đã được bác sĩ xác định dựa trên huyệt, giải phẫu, tuổi và thể trạng; không mặc định dùng tỷ lệ 1/3–2/3 thân kim cho mọi huyệt ở trẻ.

Lần lượt châm kim vào các huyệt theo công thức huyệt ghi trong y lệnh, người phụ hỗ trợ dụng cụ trong quá trình châm.

Bước 4

Người phụ tiến hành nối cặp dây của máy điện châm với kim đã châm vào huyệt theo tần số bổ- tả của máy điện châm.

Trước nối hoặc tháo dây phải đưa cường độ về không và tắt phát; kiểm tra máy, dây, vị trí cặp điện cực và hướng dẫn thiết bị. Không dùng khi chưa đánh giá nguy cơ với máy tạo nhịp hoặc thiết bị cấy ghép.

Tần số và cường độ phù hợp, theo y lệnh.

Bước 5

Lưu kim thời gian theo y lệnh.

Bước 6: Tháo máy điện châm, rút kim.

Chỉnh tần số, cường độ của máy về 0.

Tắt máy, tháo cặp dây máy điện châm.

Rút kim, sát khuẩn da vùng huyệt vừa châm.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị:

Mỗi ngày 01 lần. 02 - 45 lần/liệu trình.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Vựng châm: Người bệnh vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt, hoa mắt, chóng mặt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Chảy máu: Máu chảy tại vị trí vừa rút kim. Xử trí: Dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Gãy kim: Phát hiện kim bị gãy khi rút kim.

Xử trí: Giữ người bệnh ở tư thế gãy kim. Nếu quan sát thấy đầu kim gãy thò lên mặt da cần rút ra ngay. Trường hợp đầu kim gãy lún sâu vào trong da cần liên hệ ngoại khoa.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật:

Đau mỏi cơ vùng châm:

Nguyên nhân: do kích thích của dòng điện; hoặc do người bệnh lo lắng gây co cơ liên tục trong thời gian tiến hành thủ thuật.

Xử trí: massage nhẹ nhàng vùng cơ đau mỏi.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013), Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

10 Điện mãng châm

Mã đề xuất QT YHCT 10 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Điện mãng châm là phương pháp kết hợp giữa chữa bệnh bằng kỹ thuật mãng châm của y học cổ truyền với chữa bệnh bằng dòng điện của y học hiện đại. Dùng dòng điện tác động lên các huyệt vị qua kim châm hoặc các điện cực nhỏ đặt lên da vùng huyệt để phòng và chữa bệnh.

Kim châm sử dụng trong điện mãng châm là kim có độ dài 08 đến 30 cm và đường kính từ 0,30 đến 0,6 mm. Tùy từng huyệt, huyệt đạo trên cơ thể mà ta có thể sử dụng các kim có độ dài và đường kính tương ứng.

Hiện nay thường sử dụng máy phát ra xung điện có tính ổn định, an toàn, điều chỉnh thao tác dễ dàng, đơn giản. Kích thích của dòng điện có tác dụng làm giảm đau, giảm viêm, kích thích hoạt động các cơ, các tổ chức, tăng cường dinh dưỡng các tổ chức, ...

Trên lâm sàng thường kết hợp điện mãng châm với điện châm để điều trị các chứng bệnh nên kim châm cứu sẽ có các độ dài khác nhau.

2 Chỉ định

Các chứng liệt, chứng đau cấp tính và mạn tính.

Các bệnh lý:

+ Tiêu hóa: hội chứng dạ dày tá tràng, táo bón, rối loạn tiêu hóa, ...

+ Hô hấp: hen phế quản, viêm mũi xoang, ...

+ Cơ xương khớp: viêm quanh khớp vai, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, ...

+ Thần kinh: thất ngôn, hội chứng tiền đình, đau thần kinh liên sườn, ...

+ Tâm thần: Stress, tự kỷ, tâm căn suy nhược, ...

+ Nội tiết: thừa cân, béo phì, rối loạn tiền mãn kinh, ...

+ Sinh dục: di tinh, liệt dương, ...

+ Tiết niệu: đái dầm, bí đái cơ năng, ...

Hỗ trợ cai nghiện: rượu, ma túy, thuốc lá, ...

Châm tê phẫu thuật.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Phụ nữ có thai.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Người bệnh có rối loạn nhịp tim hoặc có đeo máy tạo nhịp.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ:

Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, dài từ 8 cm đến 30 cm, dùng riêng cho từng người.

Bông, cồn 70%.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Xe tiêm hoặc tủ đựng dụng cụ.

Máy điện châm, pin, dây nối máy.

Ống nghe, dụng cụ đo huyết áp.

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 đến 30 phút/lần.

Trong đó:

+ Thời gian châm: 5 phút.

+ Thời gian lưu kim: 20 - 25 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1.

Xác định huyệt đạo và sát khuẩn da vùng huyệt.

Chọn kim có độ dài phù hợp với độ dày của cơ vùng định châm và độ sâu của huyệt và huyệt đạo.

Bước 2. Châm kim vào huyệt theo các thì sau:

Thì 1: Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn và căng da vùng huyệt; Tay kia cầm kim bằng ngón cái và ngón trỏ, châm kim nhanh qua da vùng huyệt.

Thì 2: Đẩy kim từ từ theo huyệt đạo cho đến khi đạt“Đắc khí”.

Bước 3. Kích thích huyệt bằng máy điện châm.

Nối cặp dây của máy điện châm với kim đã châm vào huyệt theo tần số bổ- tả của máy điện châm:

Trước nối hoặc tháo dây phải đưa cường độ về không và tắt phát; kiểm tra máy, dây, vị trí cặp điện cực và hướng dẫn thiết bị. Không dùng khi chưa đánh giá nguy cơ với máy tạo nhịp hoặc thiết bị cấy ghép.

Tần số: Tần số tả từ 5 - 10Hz, tần số bổ từ 1 - 3Hz.

Điều chỉnh tần số bổ, tả theo phác đồ huyệt và tình trạng bệnh lý và giai đoạn bệnh của Người bệnh.

Cường độ: điều chỉnh tăng, giảm cường độ theo mức chịu đựng của người bệnh.

Bước 4. Đưa cường độ về không, tắt máy, tháo dây; kiểm tra đủ kim rồi rút kim và sát khuẩn da vùng huyệt.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Châm 1 đến 2 lần/ngày tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 15 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của từng bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu khi rút kim: dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Gãy kim: Tắt máy điện châm, rút tất cả các kim còn lại. Nếu phần kim gãy còn trồi trên mặt da thì nhẹ nhàng dùng panh có mấu rút kim ra, nếu phần kim gãy nằm trong cơ thì cố định vùng huyệt có kim bị gãy, chuyển ngoại khoa xử trí.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Nguyễn Tài Thu (2013), Mãng châm chữa bệnh.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

11 Giác hơi

Mã đề xuất QT YHCT 11 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Giác là dùng hơi nóng hoặc bơm hút chân không tạo thành một áp suất âm trong ống (bầu) giác, làm ống giác hút chặt vào da chỗ giác để loại bỏ tà khí, sơ thông kinh mạch, hoạt huyết khứ ứ, chỉ thống, phục hồi cân bằng âm dương.

Các phương pháp giác:

+ Giác chân không là dùng bơm hút khí trong lòng ống giác tạo áp lực âm.

+ Giác lửa là dùng lửa đẩy khí tạo áp lực âm.

+ Giác thuốc là dùng sức nóng của nước thuốc đuổi khí trong ống giác.

+ Giác kết hợp châm là phối hợp châm cứu với giác.

+ Giác kết hợp chích lể là phối hợp hai quy trình giác và chích lể.

+ Giác hơi di chuyển là dùng giác có miệng ống trơn nhẵn di chuyển trên da vùng trị liệu đã được bôi trơn bằng dầu dừa, paraphin, ...

2 Chỉ định

Các chứng đau: đau mỏi cơ khớp, đau lưng, đau vai, đau gáy, đau cổ, đau đầu, đau dạ dày, thống kinh, đau mắt, chắp lẹo, ...

Cảm mạo.

3 Chống chỉ định

Da vùng điều trị bị tổn thương, chấn thương, vết thương nhiễm khuẩn, vết thương hở, ...

Trẻ em dưới 12 tuổi.

4 Thận trọng

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Người bệnh say rượu, tâm thần.

Giảm cảm giác nóng lạnh.

Theo dõi liên tục nguồn lửa và nhiệt, bảo đảm thông khí, tránh oxy và chất dễ cháy; để chất sát khuẩn khô hoàn toàn. Không rời người bệnh khi còn ngải hoặc vật nóng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên y, lương y phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật giác hơi thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Thuốc trị bỏng (panthenol, ...).

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Ống giác thủy tinh, ống giác tre (trúc) dài 6 - 9cm, các đường kính 3cm, 4cm, 5cm hoặc bộ giác hơi chân không.

Chất đốt: cồn từ 90o trở lên, bông y tế, diêm hoặc bật lửa, paraphin hoặc dầu dừa, ...

Kim châm cứu đã tiệt khuẩn: kim hào châm để châm cứu, kim tam lăng hoặc kim lấy thuốc để chích nặn máu.

Bông tiệt khuẩn, cồn 70%.

Nước sắc bài thuốc cổ truyền phù hợp tình trạng bệnh lý của người bệnh, nồi và bếp đun, nước sạch, khăn bông sạch khô để thấm nước thuốc nóng ở miệng ống giác tre.

5.4 Trang thiết bị

Bình xịt chữa cháy.

Panh có mấu, khay đựng dụng cụ.

5.5 Người bệnh

Được khám và làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được hướng dẫn về tác dụng của giác, vị trí cần giác, cách phối hợp với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp với vùng cần giác hơi.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

15 đến 20 phút tùy từng phương pháp giác và tình trạng bệnh lý.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Người bệnh bộc lộ vị trí giác, nằm hoặc ngồi phù hợp.

Bước 2. Xác định vị trí cần giác.

Bước 3. Chọn ống giác phù hợp.

Bước 4. Chuẩn bị ống giác đã được xử lý theo phân loại dụng cụ và quy định KSNK; lau cồn 70% không thay thế làm sạch, khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn cần thiết.

Bước 5. Chọn phương pháp giác: tùy theo chứng bệnh và tình trạng bệnh mà áp dụng các kiểu giác hơi khác nhau.

Giác lửa:

Dùng panh có mấu kẹp một cầu nhỏ bông thấm cồn 90o vừa đủ (vắt kiệt không chảy cồn), dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy bông rồi xoay cầu lửa sâu vào đáy ống giác 1 đến 3 lần tùy ngọn lửa to hay bé, rút quả cầu lửa ra khỏi ống giác, sau đó úp nhanh miệng ống giác xuống vùng trị liệu, để miệng ống giác bị hút chặt.

Nhấc ống giác và lặp lại động tác.

Giác nước thuốc:

Cho nước sắc bài thuốc cổ truyền vào nồi đun sôi 2 - 3 phút thả ống giác tre vào nước thuốc, tiếp tục đun sôi 2 - 3 phút.

Dùng panh có mấu gắp ống giác ra, miệng ống giác hướng xuống dưới, vẩy cho hết nước bám vào giác, lấy khăn sạch khô thấm cho khô miệng ống giác và làm giảm sức nóng của ống giác khoảng 40–50 °C, sau đó ấn miệng ống giác xuống vị trí da nơi cần giác, miệng ống giác bị hút chặt.

Nhấc ống giác.

Giác kết hợp với châm: có 2 cách.

Cách 1: châm kim vào huyệt đến khi đạt đắc khí, làm thủ thuật tả 5 - 10 phút, rút kim, úp giác vào chỗ vừa rút kim, nhấc ống giác, sát trùng lại vùng châm.

Cách 2: châm kim vào huyệt đến khi đạt đắc khí, úp giác trùm lên kim, đốc kim cách đáy ống giác khoảng vừa phải, nhấc ống giác, sát trùng lại vùng châm.

Giác kết hợp với chích: có 2 cách.

Cách 1: sát trùng vị trí chích, dùng kim 3 cạnh chích các huyệt hoặc vùng trị liệu, giác trùm lên vết chích để hút máu, lưu ống giác 10 - 15 phút.

Cách 2: giác lên vị trí cần giác, lưu ống giác 10 - 15 phút đến khi thấy da vùng giác ửng đỏ, nhấc ống giác ra khỏi vùng trị liệu, sát trùng vị trí chích, dùng kim 3 cạnh chích da, nặn chỗ chích đến khi ra máu, sát trùng, băng lại nếu cần.

đ) Giác chân không: úp ống giác vào vị trí cần giác, sau đó dùng bơm, quả bóp hút khí trong lòng ống giác, tạo áp lực âm đủ để miệng ống giác bị hút chặt.

Giác hơi di chuyển:

Bôi dầu dừa hoặc paraphin lên vùng trị liệu.

Dùng panh có mấu kẹp một cầu nhỏ bông thấm cồn 90o vừa đủ (vắt kiệt không chảy cồn), dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy bông rồi xoay cầu lửa sâu vào đáy ống giác 1 đến 3 lần tùy ngọn lửa to hay bé, rút quả cầu lửa ra khỏi ống giác, sau đó úp nhanh miệng ống giác xuống vùng trị liệu, để miệng ống giác bị hút chặt.

Di chuyển ống giác trên da vùng trị liệu.

Nhấc ống giác, lau sạch vùng trị liệu.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Ngày giác 1 đến 2 lần.

Một liệu trình từ 5 đến 7 ngày, tùy theo từng loại bệnh có thể thực hiện nhiều liệu trình, các liệu trình có thể liên tục hoặc ngắt quãng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Choáng, shock: ngừng giác, xử trí shock theo phác đồ.

Cảm giác căng, đau, nóng rát không chịu đựng được: tháo giác.

Bỏng: xử trí bỏng theo phác đồ điều trị bỏng.

Chú ý: mặc ấm, tránh gió lạnh, không tắm trong vòng 2 giờ sau khi giác.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

12 Hào châm

Mã đề xuất QT YHCT 12 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Hào châm là phương pháp sử dụng kim nhỏ (hào kim 3 - 10 cm) để châm vào huyệt trên cơ thể nhằm mục đích phòng và trị bệnh.

Hào kim là loại kim có thân kim rất nhỏ, mũi kim nhọn, có nhiều loại dài ngắn khác nhau. Loại kim này được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh và được dùng phổ biến hiện nay.

2 Chỉ định

Bệnh cơ năng và triệu chứng của một số bệnh như rối loạn thần kinh tim, mất ngủ, kém ăn, đầy bụng, tiêu chảy, táo bón, cảm cúm, bí tiểu chức năng, nấc, ...

Các chứng đau cấp và mạn tính: đau do đụng dập, chấn thương, đau sau mổ, đau các khớp hoặc phần mềm quanh khớp, đau trong các bệnh lý về thần kinh, ...

Một số bệnh do viêm nhiễm như viêm tuyến vú, chắp, lẹo, ...

Các bệnh lý thần kinh.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên y, lương y phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, dùng riêng cho từng người bệnh.

Bông, cồn 70%.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu.

Ống nghe, dụng cụ đo huyết áp.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 đến 30 phút/lần.

Trong đó:

+ Thời gian châm: 5 phút.

+ Thời gian lưu kim: 20 - 25 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1.

Xác định và sát trùng da vùng huyệt.

Chọn kim có độ dài tùy thuộc độ dày của cơ vùng châm.

Bước 2. Châm kim vào huyệt theo các thì sau:

Thì 1: Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn và căng da vùng huyệt; Tay kia châm kim nhanh qua da vùng huyệt.

Thì 2: Đẩy kim từ từ theo huyệt đạo, kích thích kim cho đến khi đạt“Đắc khí” (Người bệnh có cảm giác căng, tức, nặng vừa phải, không đau ở vùng huyệt vừa châm kim, thầy thuốc cảm giác kim mút chặt tại vị trí huyệt), kỹ thuật đẩy kim và

kích thích tùy thuộc phương pháp bổ tả mà thầy thuốc áp dụng cho từng người bệnh và từng huyệt cụ thể.

Lần lượt châm kim vào các huyệt theo công thức huyệt ghi trong y lệnh, người phụ hỗ trợ dụng cụ trong quá trình châm.

Bước 3. Rút kim, sát khuẩn da vùng huyệt vừa châm.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Châm 1 - 2 lần/ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 1 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu khi rút kim: dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Gãy kim: Rút tất cả các kim còn lại. Nếu phần kim gãy còn trồi trên mặt da thì nhẹ nhàng dùng panh có mấu rút kim ra, nếu phần kim gãy nằm trong cơ thì cố định vùng huyệt có kim bị gãy, chuyển ngoại khoa xử trí.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

13 Mãng châm đại trường châm

Mã đề xuất QT YHCT 13 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Mãng châm là kỹ thuật dùng kim to, kim dài châm theo huyệt đạo cùng một đường kinh hoặc trên hai đường kinh khác nhau có tác dụng điều khí nhanh, mạnh hơn nên có tác dụng chữa bệnh hiệu quả cao.

Kim châm sử dụng trong mãng châm là kim có độ dài trên 10 cm và đường kính từ 0,30 đến 0,6 mm. Tùy từng huyệt, huyệt đạo trên cơ thể mà ta có thể sử dụng các kim có độ dài và đường kính tương ứng.

Trên lâm sàng có thể phối hợp mãng châm với hào châm; chọn kim phù hợp từng huyệt, hướng và độ sâu được chỉ định.

2 Chỉ định

Các chứng liệt, chứng đau cấp tính và mạn tính.

Các bệnh lý nội khoa:

+ Tiêu hóa (hội chứng dạ dày tá tràng, táo bón, rối loạn tiêu hóa, ...).

+ Hô hấp (hen phế quản, viêm mũi xoang, ...).

+ Cơ xương khớp (viêm quanh khớp vai, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, ...).

+ Thần kinh (thất ngôn, hội chứng tiền đình, đau thần kinh liên sườn, ...).

+ Tâm thần (Stress, tự kỷ, tâm căn suy nhược, ...).

+ Nội tiết (thừa cân, béo phì, rối loạn tiền mãn kinh, ...).

+ Sinh dục (di tinh, liệt dương, ...).

+ Tiết niệu (đái dầm, bí đái cơ năng, ...).

Hỗ trợ cai nghiện: rượu, ma túy, thuốc lá, ...

Châm tê phẫu thuật.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Phụ nữ có thai.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ:

Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim châm cứu vô trùng, dài từ 5 cm đến 30 cm, dùng riêng cho từng người.

Bông, cồn 70%.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Xe tiêm hoặc tủ đựng dụng cụ.

Ống nghe, dụng cụ đo huyết áp.

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 đến 30 phút/lần.

Trong đó:

+ Thời gian châm: 5 phút.

+ Thời gian lưu kim: 20 - 25 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật hoặc phòng phẫu thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1:

Xác định huyệt đạo và sát khuẩn da vùng huyệt.

Chọn kim có độ dài tùy thuộc độ dày của cơ vùng châm và độ sâu của huyệt, huyệt đạo.

Bước 2. Châm kim vào huyệt theo các thì sau:

Thì 1: Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn và căng da vùng huyệt; Tay kia cầm kim bằng ngón cái và ngón trỏ, châm kim nhanh qua da vùng huyệt.

Thì 2: Đẩy kim từ từ theo huyệt đạo cho đến khi đạt"Đắc khí".

Lần lượt châm kim vào các huyệt theo công thức huyệt ghi trong y lệnh, người phụ hỗ trợ dụng cụ trong quá trình châm

Bước 3. Rút kim, sát khuẩn da vùng huyệt vừa châm.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu khi rút kim: dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Gãy kim: Rút tất cả các kim còn lại. Nếu phần kim gãy còn trồi trên mặt da thì nhẹ nhàng dùng panh có mấu rút kim ra, nếu phần kim gãy nằm trong cơ thì cố định vùng huyệt có kim bị gãy, chuyển ngoại khoa xử trí.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Nguyễn Tài Thu (2013), Mãng châm chữa bệnh.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

14 Kéo nắn cột sống cổ bằng phương pháp y học cổ truyền

Mã đề xuất QT YHCT 14 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Theo Y học hiện đại đau vùng cổ vai thường do nguyên nhân thoái hóa cột sống cổ. Tùy theo mức độ và vị trí tổn thương của đốt sống cổ người bệnh có những triệu chứng như: cơ vùng cổ vai co cứng, đau hoặc tê có thể lan xuống vùng tay, có thể một hoặc hai bên, hạn chế các động tác vùng cổ vai như vận động cổ, cúi, ngửa, nghiêng, xoay.

Theo Y học cổ truyền, đau cổ vai do thoái hóa cột sống cổ được xếp vào chứng tý. Nguyên nhân gây ra: do tấu lý sơ hở phong hàn thấp thừa cơ xâm nhập gây tổn thương kinh lạc, cản trở lưu thông khí huyết gây đau. Do lao động vất vả, do ăn uống, tình dục không điều độ, đàm ẩm hoặc do chấn thương gây bế tắc kinh lạc vùng cổ vai gây đau, hạn chế vận động.

Kéo nắn cột sống cổ theo phương pháp Y học cổ truyền dựa trên nguyên lý cơ học có tác dụng giãn cơ, thông kinh hoạt lạc, lưu thông khí huyết từ đó có tác dụng giảm đau.

2 Chỉ định

Thoái hóa cột sống cổ.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

Hội chứng cổ vai cánh tay.

Đau cổ vai cấp.

3 Chống chỉ định

Tổn thương thực thể cột sống: ung thư, lao, viêm tấy, áp xe vùng cổ.

Chấn thương cột sống cổ có gãy xương, biến dạng.

Bệnh lý tủy sống và ống sống.

Viêm cột sống dính khớp.

Loãng xương nặng, suy kiệt.

Cơn tăng huyết áp, các bệnh tim nặng.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có chỉ định điều trị ngoại khoa.

Thoái hóa cột sống cổ có cầu xương.

4 Thận trọng

Trẻ em.

Phụ nữ có thai.

Khám loại trừ thiếu hụt thần kinh tiến triển và dấu hiệu cảnh báo; dừng và đánh giá ngay khi đau tăng, chóng mặt, nhìn mờ, yếu hoặc tê mới. Không tự thêm thao tác xoay giật cổ, xung lực ngoài kỹ thuật đã được phê duyệt.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật kéo nắn cột sống cổ bằng phương pháp y học cổ truyền thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Không có thuốc riêng bắt buộc; sử dụng thuốc khi có chỉ định.

5.3 Vật tư

Găng tay y tế.

Bột talc.

Dung dịch sát khuẩn.

Khăn xoa bóp.

Khẩu trang giấy.

5.4 Trang thiết bị

Giường thủ thuật, ghế.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị tư thế phù hợp.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Bệnh án chẩn đoán hoặc sổ khám bệnh chẩn đoán, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và phiếu chỉ định của bác sĩ.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện thủ thuật không quá 20 phút (Điều trị thoát vị đĩa đệm, thời gian kéo nắn lần đầu chỉ nên từ 10 - 15 phút).

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1: sát khuẩn tay.

Bước 2: Dùng các thủ thuật làm mềm cơ (áp, vuốt, ấn và miết…).

Bước 3: Tiến hành kéo nắn cột sống.

Nếu người bệnh nằm ngửa:

Đầu thân và chân tay tạo thành một đường thẳng.

Thầy thuốc tay trái đặt dưới gáy, tay phải đặt trên trán người,nhấc đầu người bênh lên cao tạo thành 1 góc 30 độ so với mặt giường, dùng lực kéo phù hợp về phía thầy thuốc từ 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 10 giây đến 20, dùng lực mạnh phù hợp kéo đầu người bệnh trong khoảng 1 đến 2 giây.

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi tại giường 3-5 phút, hướng dẫn người bệnh ngồi dậy theo tư thế nằm nghiêng.

Nếu người bệnh ngồi:

Ngồi thẳng lưng, đầu thân tạo thành 1 đường thẳng.

Thầy thuốc đứng sau người bệnh, đan tay vào nhau đặt dưới cằm người bệnh, dùng lực nâng đầu người bệnh lên từ 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 30 giây đến 1 phút.

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi 3-5 phút.

Bước 4: kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi thực hiện thủ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Mỗi ngày thực hiện thủ thuật 1 lần, 1 liệu trình từ 5 – 7 ngày, có thể thực hiện nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện thủ thuật.

Đau tăng, tổn thương phần mềm cạnh cột sống, ...

Xử trí: dừng toàn bộ kéo nắn khi đau tăng hoặc nghi tổn thương; đánh giá thần kinh, mạch máu và báo bác sĩ. Không tiếp tục tác động các vị trí khác trước khi xác định an toàn.

Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật.

Đau tăng lên, xử trí thuốc giảm đau theo bậc thang điều trị đau.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Học viện y dược cổ truyền Việt Nam (2013). Bài giảng tác động cột sống tập I.

Trương Đại học Y khoa Hà Nội (2004). Bài giảng Y học cổ truyền tập II.

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2008). Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

15 Kéo nắn cột sống thắt lưng theo phương pháp y học cổ truyền

Mã đề xuất QT YHCT 15 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Theo Y học hiện đại đau vùng thắt lưng thường do nguyên nhân thoái hóa cột sống lưng. Tùy theo mức độ và vị trí tổn thương của đốt sống lưng người bệnh có những triệu chứng như: vùng thắt lưng cứng đau, đau hoặc tê có thể lan xuống vùng hông chân, đau có thể một hoặc hai bên, cơ vùng lưng co cứng, hạn chế các động tác vùng lưng như vận động lưng, cúi, ngửa, nghiêng xoay.

Theo Y học cổ truyền, nguyên nhân gây ra đau thắt lưng do thoái hóa cột sống là do tấu lý sơ hở phong hàn thấp thừa cơ xâm nhập gây tổn thương kinh lạc, cản trở lưu thông khí huyết gây đau. Do lao động vất vả, do ăn uống, tình dục không điều độ, đàm ẩm hoặc do chấn thương gây bế tắc kinh lạc vùng thắt lưng gây đau, hạn chế vận động.

Kéo nắn cột sống lưng theo phương pháp Y học cổ truyền dựa trên nguyên lý cơ học có tác dụng giãn cơ, thông kinh hoạt lạc, lưu thông khí huyết từ đó có tác dụng giảm đau.

2 Chỉ định

Thoái hóa cột sống lưng.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Hội chứng đau thắt lưng do nguyên nhân ngoại vi (cơ, dây chằng).

Đau lưng cấp.

3 Chống chỉ định

Tổn thương thực thể cột sống: ung thư, lao, viêm tấy, áp xe vùng lưng.

Chấn thương cột sống lưng có gãy xương, biến dạng.

Bệnh lý tủy sống và ống sống.

Thoái hóa cột sống có các cầu xương nối các đốt sống.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có chỉ định điều trị ngoại khoa.

Viêm cột sống dính khớp.

Loãng xương nặng.

Người bệnh suy kiệt.

Các bệnh tim nặng.

Phụ nữ có thai.

4 Thận trọng

Trẻ em.

Khám loại trừ thiếu hụt thần kinh tiến triển và dấu hiệu cảnh báo; dừng và đánh giá ngay khi đau tăng, chóng mặt, nhìn mờ, yếu hoặc tê mới. Không tự thêm thao tác xoay giật cổ, xung lực ngoài kỹ thuật đã được phê duyệt.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật kéo nắn cột sống thắt lưng bằng phương pháp y học cổ truyền thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Không có thuốc riêng bắt buộc; sử dụng thuốc khi có chỉ định.

5.3 Vật tư

Khăn xoa bóp.

Gối.

Dung dịch sát khuẩn.

Khăn xoa bóp.

Khẩu trang giấy.

5.4 Trang thiết bị

Giường thủ thuật.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị tư thế phù hợp.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Bệnh án chẩn đoán hoặc sổ khám bệnh chẩn đoán, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và phiếu chỉ định của bác sĩ.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện thủ thuật không quá 20 phút (Điều trị thoát vị đĩa đệm, thời gian kéo nắn lần đầu chỉ nên từ 10 - 15 phút).

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1: sát khuẩn tay.

Bước 2: Dùng các thủ thuật làm mềm cơ (áp, vuốt, ấn, miết,…).

Bước 3: Tiến hành kéo nắn cột sống.

Người bệnh nằm sấp; tay, chân duỗi thẳng theo thân mình; cổ chân đặt lên gối.

Thầy thuốc, đặt tay trái đặt vùng giữa cột sống thắt lưng, tay phải cầm cổ chân, dùng lực kéo giãn dần dần đạt đến ngưỡng, giữ 10- 20 giây, thả dần tay.Thực hiện tương tự với bên còn lại.

Bước 4: Giúp người bệnh về tư thế nằm ngửa, nghỉ ngơi tại giường 3-5 phút.

Bước 5: kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi thực hiện thủ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Mỗi ngày thực hiện 1 lần, 1 liệu trình từ 5 - 7 ngày, có thể thực hiện nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện thủ thuật.

Đau tăng, tổn thương phần mềm cạnh cột sống, ...

Xử trí: dừng toàn bộ kéo nắn khi đau tăng hoặc nghi tổn thương, đánh giá thần kinh mạch máu và báo bác sĩ; không tiếp tục ở vị trí khác trước khi xác định an toàn.

Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật.

Đau tăng lên, xử trí thuốc giảm đau theo bậc thang điều trị đau.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Học viện y dược cổ truyền Việt Nam (2013). Bài giảng tác động cột sống tập I.

Trường Đại học Y khoa Hà Nội (2004). Bài giảng Y học cổ truyền tập II.

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2008). Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

16 Laser châm

Mã đề xuất QT YHCT 16 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Laser châm là sử dụng ánh sáng đơn sắc phát ra từ một thiết bị Laser công suất thấp (<=250 milliwatt) chiếu vào các huyệt trên hệ thống kinh lạc nhằm điều hòa khí huyết, giúp cơ thể lập lại cân bằng âm dương để điều trị và phòng bệnh.

Laser châm được chỉ định tương đối rộng rãi để điều trị các chứng bệnh. Laser châm có thể dùng riêng biệt hoặc kết hợp với điện châm ở các vị trí huyệt khác nhau, với xoa bóp bấm huyệt và một số phương pháp khác.

2 Chỉ định

Bệnh cơ năng và triệu chứng của một số bệnh như rối loạn thần kinh tim, mất ngủ, kém ăn, đầy bụng, tiêu chảy, táo bón, cảm cúm, bí tiểu chức năng, nấc, ...

Các chứng đau cấp và mạn tính: đau do đụng dập, chấn thương, đau sau mổ, đau các khớp hoặc phần mềm quanh khớp, đau trong các bệnh lý về thần kinh, ...

Một số bệnh do viêm nhiễm như viêm tuyến vú, chắp, lẹo, ...

Các bệnh lý thần kinh.

3 Chống chỉ định

Người bệnh động kinh.

Người bệnh cường giáp.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Da vùng châm bị tổn thương hoặc có hình săm, có khối u ác tính ở vùng châm.

Vùng thóp, đầu các xương dài của trẻ vị thành niên, cạnh các tuyến nội tiết (tuyến giáp, tinh hoàn, ...), vùng mắt.

Có tiền sử động kinh.

Người bệnh có rối loạn nhịp tim hoặc có đặt máy tạo nhịp.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật Laser châm theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Bông, cồn 70%.

Băng dính cố định đầu chiếu tia laser.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Máy laser công suất thấp bao gồm dây dẫn tia laser và đầu chiếu tia laser.

Kính bảo vệ laser đúng bước sóng và mật độ quang học theo thiết bị cho người bệnh, nhân viên và người có mặt trong vùng kiểm soát.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được điều trị.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian điều trị tuỳ thuộc vào liều điều trị và số huyệt được lựa chọn.

Thông thường thời gian điều trị bằng Laser châm từ 15 - 30 phút/lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác định phác đồ huyệt.

Bước 2. Xác định liều điều trị.

Liều điều trị phụ thuộc vào từng loại huyệt và tình trạng bệnh lý của người bệnh (bệnh cấp tính dùng liều thấp, bệnh mạn tính dùng liều cao). Liều điều trị được tính bằng J/cm2. Điều chỉnh máy, chọn các tham số kỹ thuật phù hợp với liều điều trị.

Loại huyệt	**Liều**
A thị huyệt	1 - 2 J/cm²

Loại huyệt	Liều
Huyệt giáp tích	2 - 4 J/cm²
Huyệt châm cứu ở người lớn	1 - 3 J/cm²
Huyệt châm cứu ở trẻ em	0,5 - 1,5 J/cm²

Bước 3.

Xác định chính xác và sát trùng da vùng huyệt, dùng kỹ thuật chiếu điểm (chiếu tia thẳng góc với huyệt), giữ đầu phát tại chỗ cho đến khi hết thời gian điều trị (có thể dùng băng dính cố định đầu phát tia lên bề mặt da nơi vị trí các huyệt theo phác đồ).

Kết thúc điều trị

Chỉnh các nút cường độ của máy về “0” rồi tắt công tắc nguồn.

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Bệnh cấp tính: mỗi ngày điều trị 01 lần, mỗi liệu trình 5 - 10 ngày.

Bệnh mạn tính: mỗi ngày điều trị 01 lần, mỗi liệu trình điều trị từ 1-2 tuần. Có thể điều trị nhiều liệu trình.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Người bệnh xuất hiện các nốt đỏ ở da, mẩn ngứa (do cơ địa quá mẫn cảm với ánh sáng), tạm dừng điều trị 1 - 3 ngày cho đến khi hết các nốt đỏ.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

* Chú ý:

Không được chiếu tia Laser vào mắt.

Da và các vùng huyệt không được bôi dầu, mỡ hay các loại kem, gel (làm tia Laser bị phản xạ một phần và ảnh hưởng đến mức độ đâm xuyên của tia).

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu.

Bộ Y tế (2022), Quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

17 Ngâm thuốc y học cổ truyền bộ phận

Mã đề xuất QT YHCT 17 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Ngâm thuốc y học cổ truyền (thuốc cổ truyền) bộ phận là phương pháp dùng thuốc cổ truyền dạng sắc hoặc hãm các thuốc cổ truyền để ngâm bộ phận cơ thể bị bệnh để nhằm mục đích phòng bệnh và chữa bệnh. Thường dùng các thuốc có tác dụng giải biểu, khu phong, tán hàn, trừ thấp, hoạt huyết tiêu viêm, lưu thông kinh lạc, …

Mục đích điều hoà hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hoá, thần kinh, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng chuyển hoá, chống viêm, chống stress và điều hoà cơ thể, giảm đau, …

2 Chỉ định

Viêm khớp, đau khớp, đau và viêm dây thần kinh, đau cơ, bong gân, cứng khớp, teo cơ, hạn chế vận động, sẹo co kéo, mỏm cụt đau, …

Bệnh ngoài da: viêm da dị ứng, tổ đỉa, nấm, chàm, …

Trĩ, nứt kẽ hậu môn, viêm phần phụ, sa sinh dục, sa trực tràng, …

Rối loạn thần kinh thực vật: mồ hôi lòng bàn tay, bàn chân, một số bệnh rối loạn vận mạch, …

Suy nhược thần kinh, mất ngủ, bệnh béo phì, rối loạn chuyển hóa Lipoprotein, giải độc, …

3 Chống chỉ định

Bệnh cấp cứu và các chấn thương cấp tính.

Suy giãn tĩnh mạch.

Vết thương nhiễm khuẩn, vết thương hở, vết loét hóa mủ.

Các khối u ác tính, lao tiến triển.

Dị ứng các thành phần của thuốc.

4 Thận trọng

Các trường hợp rối loạn cảm giác nóng lạnh.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Người bệnh say rượu, tâm thần.

Tăng huyết áp chưa kiểm soát, huyết áp thấp.

Người bệnh trong trạng thái đói.

Người có tiền sử động kinh.

Trẻ em dưới 12 tháng tuổi, người già sa sút trí tuệ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ, lương y thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật ngâm thuốc cổ truyền bộ phận thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sử dụng bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền của mình đã được cấp có thẩm quyền công nhận, cấp phép theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Thuốc cổ truyền phù hợp (Nước thuốc ngâm của bài thuốc hoặc thuốc bột để hãm với nước sôi).

Thuốc trị bỏng (Panthenol, …).

Hộp thuốc cấp cứu phản vệ.

5.3 Vật tư

Khăn cotton với kích thước phù hợp (để lau tay, lau cơ thể, ...)

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước.

Quần áo sạch để thay.

Xà phòng rửa tay.

Dầu tắm, dầu gội đầu.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Bàn chải, dung dịch vệ sinh bồn ngâm bộ phận, chậu ngâm; dung dịch vệ sinh phòng điều trị.

Găng tay cao su, dép chống trơn trượt.

Nước uống.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ đun nước nóng (ấm đun siêu tốc hoặc nồi) hoặc phích nước nóng.

Bồn ngâm bộ phận hoặc chậu ngâm.

Xô đựng nước thuốc.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc: Khám và làm bệnh án theo quy định, hướng dẫn quy trình ngâm thuốc để người bệnh yên tâm hợp tác. Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh.

Người bệnh tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án đúng tên tuổi người bệnh, đúng chẩn đoán.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

Ngâm thuốc 15 - 30 phút/lần, 1 - 2 lần/ngày tuỳ thuộc vào vị trí, tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

1 liệu trình điều trị từ 10 - 20 ngày, tuỳ theo mức độ và diễn biến của từng bệnh, có thể tiến hành 2 - 3 liệu trình liên tục.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Người bệnh được uống đủ nước, bộc lộ và làm sạch bộ phận cần ngâm.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1: Sát khuẩn tay.

Bước 2. Chuẩn bị chậu ngâm/bồn ngâm bộ phận và nước thuốc ngâm (đựng trong xô đựng thuốc ngâm).

Bước 3. Kiểm tra nhiệt độ của nước ngâm xem nóng quá hoặc chưa đủ nóng để điều chỉnh, nhiệt độ thích hợp từ 35 - 39oC.

Bước 4: Ngâm bộ phận cần điều trị vào nước thuốc.

Bước 5: Trong quá trình ngâm thuốc có thể kết hợp với kỹ thuật xoa bóp vùng trị liệu để tăng hiệu quả.

Bước 6: Làm sạch vùng trị liệu vừa ngâm bằng nước sạch, lau khô bằng khăn. Người bệnh uống nước bổ sung.

Bước 7: Kết thúc quy trình.

Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Trong quá trình ngâm theo dõi nhiệt độ nước ngâm đề phòng bị bỏng.

Cảm giác căng, đau, nóng rát không chịu đựng được->pha nước vào chậu ngâm giảm nhiệt độ hoặc ngừng ngâm.

- Tại chỗ:

+ Bỏng do nước quá nóng, xử lý bỏng theo phác đồ điều trị bỏng.

+ Dị ứng với thuốc ngâm: dừng ngâm, làm sạch thuốc trên da bằng nước sạch.

Dùng thuốc điều trị dị ứng.

- Toàn thân: Cho người bệnh nằm nghỉ nếu thấy mệt mỏi, chóng mặt. Choáng, shock: ngừng ngâm, xử trí shock theo phác đồ.

Chú ý: mặc ấm, tránh gió lạnh.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020- Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền - Nhà xuất bản y học 2021, trang 26,28.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

18 Ôn châm

Mã đề xuất QT YHCT 18 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Châm là sử dụng kim châm cứu để châm vào huyệt trên cơ thể, cứu là dùng sức nóng từ mồi ngải hoặc điếu ngải tác động vào huyệt để phòng và điều trị bệnh. Ôn châm kết hợp giữa châm và cứu trên cùng một huyệt để đạt tác dụng phòng và điều trị bệnh của hai phương pháp trên.

2 Chỉ định

Bệnh lý có nguyên nhân hàn có chỉ định châm cứu.

Các bệnh mạn tính, thể trạng hư nhược.

Các chứng đau cấp và mạn tính do hàn.

3 Chống chỉ định

Các bệnh thuộc nhiệt chứng.

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Người bệnh đang trong trạng thái kích động, kích thích, sợ hãi.

4 Thận trọng

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng ôn châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng ôn châm.

Người bệnh có rối loạn cảm giác.

Các vùng da mỏng, nhiều gân, vùng da sát xương, vùng mặt.

Người bệnh đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Theo dõi liên tục nguồn lửa và nhiệt, bảo đảm thông khí, tránh oxy và chất dễ cháy; để chất sát khuẩn khô hoàn toàn. Không rời người bệnh khi còn ngải hoặc vật nóng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y, lương y phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần.

Khay, bông và cồn 70%.

Mồi ngải hoặc điếu ngải.

Lửa (diêm, bật lửa...).

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Kìm có mấu

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng, theo quy định.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25–30 phút/lần theo nguồn, gồm thời gian châm khoảng 5 phút và lưu kim 20–25 phút; điều chỉnh theo chỉ định và dung nạp.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra phiếu chỉ định đúng danh tính, chẩn đoán, kỹ thuật và vị trí của người bệnh.

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác định phác đồ huyệt.

Bước 2.

Châm kim vào huyệt theo phác đồ điều trị.

Có phương tiện hứng tàn và bảo vệ da; kiểm soát ngọn lửa, tránh oxy, chất dễ cháy, để dung dịch sát khuẩn khô hoàn toàn. Dập hết ngải và loại bỏ vật nóng trước rút kim.

Có thể dùng ba cách làm nóng kim để ôn châm:

+ Xuyên kim qua mồi ngải cứu gián tiếp trên huyệt.

+ Lồng một đoạn điếu ngải vào cán kim rồi đốt.

+ Hơ điếu ngải gần cán kim cho kim nóng lên, sức nóng theo kim truyền vào sâu.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Đếm số kim vào và ra, kiểm tra kim nguyên vẹn; bỏ kim dùng một lần ngay vào hộp kháng thủng, không tái sử dụng hoặc đậy lại bằng hai tay.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Ôn châm 1 - 2 lần/ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 1 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Cháy: do mồi ngải rơi khỏi người người bệnh vướng vào quần áo hoặc chăn đệm gây cháy. Cần chú ý theo dõi sát người bệnh khi thực hiện kỹ thuật cứu.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Bỏng: đánh giá độ sâu và diện tích thực tế, không mặc định là bỏng độ I khi xuất hiện phỏng nước.

+ Triệu chứng: người bệnh thấy nóng rát sau khi cứu, trên mặt da vùng huyệt được cứu xuất hiện phỏng nước.

Xử trí: dừng nguồn nhiệt, đánh giá tổn thương và xử trí theo phác đồ bỏng; không mặc định bôi thuốc mỡ cho mọi mức độ.

Chảy máu khi rút kim: Dùng bông khô vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu".

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

19 Thủy châm tiêm thuốc vào huyệt

Mã đề xuất QT YHCT 19 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Thủy châm (hay tiêm thuốc vào huyệt) là một phương pháp chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, phối hợp tác dụng chữa bệnh của châm theo học thuyết kinh lạc theo y học cổ truyền với tác dụng chữa bệnh của thuốc, duy trì thời gian kích thích lên huyệt vị nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Chỉ chọn thuốc phù hợp chỉ định, đường tiêm bắp và hướng dẫn sử dụng được phê duyệt; tên thuốc, nồng độ, tổng liều và thể tích từng huyệt phải ghi trong y lệnh.

2 Chỉ định

Các chứng liệt (liệt do tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt, liệt các dây thần kinh ngoại biên): Các bệnh lý đau như đau đầu, đau lưng, đau thần kinh tọa; Bệnh ngũ quan như giảm thị lực, giảm thính lực, thất ngôn.

Các chứng đau cấp và mạn tính: Đau do đụng giập, chấn thương, đau sau mổ, đau các khớp hoặc phần mềm quanh khớp, đau trong các bệnh lý về thần kinh, ...

Bệnh cơ năng và triệu chứng của một số bệnh như rối loạn thần kinh tim, mất ngủ không rõ nguyên nhân, kém ăn, đầy bụng, tiêu chảy, táo bón, cảm cúm, bí tiểu chức năng, nấc, ...

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Các thuốc gây hoại tử tổ chức: Calci Clorua, đường ưu trương.

Người bệnh có chống chỉ định của thuốc thủy châm;

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu;

Các bệnh có chỉ định ngoại khoa;

Da bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm;

Người bệnh trong trạng thái kích thích, sợ hãi quá mức.

4 Thận trọng

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da vùng châm bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng châm.

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

Huyệt vùng sát xương, phía dưới là tạng phủ, khớp, dây chằng, thần kinh, mạch máu.

Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc hoặc dị nguyên có liên quan (thuốc, dị nguyên cùng nhóm hoặc có phản ứng chéo) và nếu người bệnh có tiền sử phản vệ với nhiều dị nguyên khác nhau quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật thủy châm theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật thủy châm thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Thuốc theo y lệnh, phù hợp đường tiêm bắp; kiểm tra tên, nồng độ, hạn dùng, dị ứng, liều tối đa và khả năng tương thích. Không mặc định mọi thuốc tiêm bắp đều phù hợp mọi huyệt.

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Bơm tiêm vô khuẩn, dùng riêng cho từng người bệnh.

Kim lấy thuốc.

Bông, gạc vô trùng, cồn 70%.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Khay đựng dụng cụ y tế, kẹp có mấu.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được châm.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 - 30 phút/lần, trong đó: thời gian thực hiện 10 - 15 phút, theo dõi người bệnh sau thủy châm 15 phút.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra 5 đúng theo quy định.

Bước 2. Sát khuẩn tay theo quy định, đeo găng tay.

Bước 3. Lấy thuốc vào bơm tiêm.

Bước 4. Tiến hành thủy châm theo các thì sau:

Thì 1: Xác định và sát trùng da vùng huyệt theo phác đồ. Dùng hai ngón tay ấn và căng da vùng huyệt, tay còn lại châm kim nhanh qua da, đẩy kim tới huyệt, Người bệnh thấy cảm giác tức nặng tại vị trí kim châm.

Thì 2. Kiểm tra theo kỹ thuật tiêm vào huyệt; nếu có máu trong bơm, đau chói, tê lan hoặc sức cản bất thường thì dừng và đánh giá. Bơm chậm theo thể tích từng huyệt đã chỉ định; mức 0,1–3 mL trong nguồn không thay thế giới hạn của thuốc, giải phẫu và tuổi. Không tự chia hoặc tăng tổng liều.

Thì 3: Rút kim nhanh, sát trùng vị trí tiêm.

Lưu ý: Không thủy châm 02 lần liên tiếp vào các huyệt ở vùng cơ mỏng.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Thủy châm một ngày một lần, mỗi lần thủy châm vào 1 - 5 huyệt.

Một liệu trình điều trị từ 1 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh, có thể tiến hành nhiều liệu trình liên tục.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Phản vệ: xử trí phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế.

Vựng châm: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Chảy máu khi rút kim: dùng bông vô khuẩn ấn tại chỗ, không day.

Đau tại vị trí huyệt được thủy châm.

Xử trí: Chườm lạnh, dùng thuốc giảm đau nếu cần.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Khó thở, đau ngực, ho hoặc giảm oxy sau châm/cấy vùng ngực, cổ, vai: ngừng, đánh giá ABCDE và gọi bác sĩ cấp cứu; nghĩ đến tổn thương sâu hoặc tràn khí màng phổi, không chỉ coi là vựng châm. Phản vệ: kích hoạt cấp cứu, thực hiện phác đồ với adrenaline, không dùng nước uống hoặc thuốc kháng histamine thay xử trí.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

20 Xoa bóp bấm huyệt

Mã đề xuất QT YHCT 20 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Xoa bóp bấm huyệt là phương pháp điều trị, người thầy thuốc sử dụng tay của mình tác động lên da, cơ, các huyệt vị, xương khớp của người bệnh nhằm mục đích phòng và điều trị bệnh.

Theo y học cổ truyền xoa bóp bấm huyệt bao gồm các kỹ thuật: xoa, xát, miết, phân, hợp, véo, vỗ, phát, bóp, đấm, chặt, lăn, rung, day huyệt, ấn huyệt, bấm huyệt, điểm huyệt, vê khớp, vận động khớp, kéo giãn khớp, ... có tác dụng thư cân, giải cơ, thông kinh hoạt lạc, điều hòa dinh vệ và điều hòa chức năng tạng phủ.

2 Chỉ định

Các chứng đau, các chứng liệt, các chứng bệnh nội khoa, các bệnh nhi khoa.

Phục hồi chức năng sau can thiệp ngoại khoa.

Phục hồi sức khoẻ sau lao động nặng, luyện tập thể thao, ...

Rối loạn chức năng cơ thể: bí đái cơ năng, rối loạn thần kinh thực vật, đái dầm, ...

Rối loạn tâm thần kinh: mất ngủ, Stress, tâm căn suy nhược, ...

Các chứng suy nhược.

Nâng cao thể trạng.

3 Chống chỉ định

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

Lao xương, lao cột sống, …

4 Thận trọng

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Da bị tổn thương, có khối u ác tính ở vùng xoa bóp bấm huyệt.

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Phụ nữ có thai.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Người bệnh loãng xương nặng, người có nguy cơ gãy xương.

Sau ăn quá no hoặc quá đói.

Người bệnh có nguy cơ chảy máu.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên y, lương y phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ:

+ Điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

5.2 Thuốc

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Bột talc, gel, kem, dầu xoa bóp, …

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Bàn chải rửa tay.

5.4 Trang thiết bị

Bố trí giường hoặc ghế thủ thuật và phương tiện theo dõi, gọi hỗ trợ phù hợp kỹ thuật.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được xoa bóp bấm huyệt.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi đầy đủ thông tin người bệnh, chẩn đoán và chỉ định rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

20 - 30 phút/ lần với xoa bóp bấm huyệt bộ phận.

60 phút/ lần với xoa bóp bấm huyệt toàn thân.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra phiếu chỉ định đúng danh tính, chẩn đoán, kỹ thuật và vị trí người bệnh.

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Tuân thủ nguyên tắc xoa bóp bấm huyệt:

Từ nhẹ đến mạnh;

Từ chậm đến nhanh;

Từ nông đến sâu;

Từ xa đến gần (vùng đau).

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng vị trí, tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh. Có thể kết hợp thực hiện nhiều thủ pháp của xoa bóp bấm huyệt trong cùng một thời điểm và kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Bước 1. Sát khuẩn tay.

Bước 2. Thực hiện kỹ thuật tác động lên da:

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng vùng cơ thể của Người bệnh để thực hiện: Xoa; Xát; Miết; Phân; Hợp; Véo; Vỗ; Phát.

Bước 3. Thực hiện kỹ thuật tác động lên cơ:

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng vùng cơ thể của Người bệnh để thực hiện: Day; Bóp; Đấm; Chặt; Lăn; Vê; Vờn.

Bước 4. Thực hiện kỹ thuật tác động lên huyệt:

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng chứng bệnh và từng vùng cơ thể của Người bệnh để thực hiện: Day huyệt; Ấn huyệt; Bấm huyệt; Điểm huyệt.

Bước 5. Thực hiện kỹ thuật tác động lên khớp:

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng chứng bệnh và từng khớp cụ thể của Người bệnh để thực hiện: Vê khớp; Vận động khớp; Kéo giãn khớp; Rung.

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Xoa bóp bấm huyệt 1 đến 2 lần/ngày, tùy thuộc vào vị trí, tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 1 - 30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của từng bệnh, có thể tiến hành 2 - 3 liệu trình liên tục hoặc điều trị liên tục đến khi bệnh hồi phục hoặc để tránh bị các thương tật thứ phát (teo cơ, cứng khớp, loét, ...).

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Choáng: Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

+ Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Đau: Người bệnh đau tăng tại vùng xoa bóp bấm huyệt.

+ Xử trí: Xoa nhẹ vùng đau, giảm cường độ tác động lên vùng điều trị; có thể dừng thủ thuật nếu người bệnh quá nhạy cảm với các tác động trên cơ thể. Dùng thuốc hóa dược nếu cần.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Biến chứng muộn: tiếp tục theo dõi triệu chứng tại chỗ và toàn thân; không khẳng định không thể xảy ra.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Tài Thu (2013), Tân châm.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

21 Xoa bóp bấm huyệt cho trẻ nhi

Mã đề xuất QT YHCT 21 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Xoa bóp bấm huyệt là phương pháp điều trị, người thầy thuốc sử dụng tay của mình tác động lên da, cơ, các huyệt vị, xương khớp của người bệnh nhằm mục đích phòng và điều trị bệnh.

Theo y học cổ truyền xoa bóp bấm huyệt bao gồm các kỹ thuật: xoa, xát, miết, phân, hợp, véo, vỗ, phát, bóp, đấm, chặt, lăn, rung, day huyệt, ấn huyệt, bấm huyệt, điểm huyệt, vê khớp, vận động khớp, kéo giãn khớp, ... có tác dụng thư cân, giải cơ, thông kinh hoạt lạc, điều hòa dinh vệ và điều hòa chức năng tạng phủ.

Thao tác xoa bóp bấm huyệt trên trẻ nhi cần nhẹ nhàng, đảm bảo khống chế lực tác động lên trẻ, tránh gây kích thích sợ hãi làm giảm tác dụng của thủ thuật.

2 Chỉ định

Bệnh lý thần kinh, tâm thần: đau đầu, rối loạn giấc ngủ, stress, chậm phát triển do các nguyên nhân, rối loạn phổ tự kỷ, các rối loạn Tic và hội chứng Tourette, …, chứng liệt do các nguyên nhân (liệt do tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt, liệt các dây thần kinh ngoại biên, bệnh dây thần kinh mặt, …); viêm đa dây, rễ, đám rối thần kinh, đau dây thần kinh liên sườn, bệnh dây thần kinh tam thoa, …

Bệnh lý cơ xương khớp: vẹo cổ cấp, đau vùng cổ gáy, đau lưng, bệnh khớp (viêm khớp tự miễn, viêm khớp thiếu niên, …), bệnh cột sống, các bệnh cơ, các bệnh lý mô mềm, …

Bệnh lý hô hấp: viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, hen phế quản, viêm họng, viêm Amydal, …

Bệnh lý tiêu hóa: hội chứng ruột kích thích, hội chứng dạ dày - tá tràng, táo bón, đại tiện són phân, bệnh lý đường mật, sa trực tràng …

Bệnh lý phụ khoa: đau và tình trạng khác liên quan đến cơ quan sinh dục nữ và chu kỳ kinh nguyệt, …

Bệnh lý ngũ quan: lác, các bệnh thần kinh thị giác, ù tai, giảm thính lực, …

Bệnh lý tiết niệu: đái dầm, bí tiểu, rối loạn tiểu tiện, …

Các bệnh lý khác: rối loạn chức năng tiền đình, giảm đau trong ung thư, giảm đau sau phẫu thuật, cai nghiện (games, thuốc lá…), …

Phục hồi chức năng sau can thiệp ngoại khoa.

Phục hồi chức năng cho các người bệnh phải nằm giường lâu ngày.

Nâng cao thể trạng.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu.

Các bệnh có chỉ định ngoại khoa.

Chấn thương ngoại khoa.

Các chấn thương có đụng giập cơ.

Da bị tổn thương, có bệnh da liễu, có khối u ác tính ở vùng xoa bóp.

Các bệnh ưa chảy máu, vùng đang chảy máu, xuất huyết dưới da.

4 Thận trọng

Người bệnh sốt cao, đang mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Giai đoạn nặng của bệnh: suy tim, suy gan, suy thận; cơ thể suy kiệt nặng.

Người bệnh loãng xương nặng, có nguy cơ gãy xương, trẻ mắc bệnh tạo xương bất toàn.

Ngay sau khi ăn no, khi đói.

Người bệnh trong trạng thái kích thích, sợ hãi quá mức.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

a, Nhân lực trực tiếp

Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên, lương y đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa y học cổ truyền hoặc có trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt thực hiện theo phạm vi hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

b, Nhân lực hỗ trợ

Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Không có thuốc riêng bắt buộc; sử dụng thuốc khi có chỉ định.

5.3 Vật tư

Bột talc, gel hoặc dầu xoa bóp.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khăn lau tay, găng tay, khẩu trang.

5.4 Trang thiết bị

Bố trí giường hoặc ghế thủ thuật và phương tiện theo dõi, gọi hỗ trợ phù hợp kỹ thuật.

5.5 Người bệnh

Thầy thuốc giải thích cho người bệnh, người nhà về kỹ thuật trước khi thực hiện: mục đích, các bước tiến hành, biến chứng, nguy cơ có thể xảy ra, tiên lượng, ...

Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

20 - 45 phút/lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đặt người bệnh ở tư thế thoải mái, phù hợp nhất; trẻ sợ hãi cần có người bế, giữ; bộc lộ vùng cần tiến hành kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Lựa chọn các thủ thuật thích hợp với từng vị trí, tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh. Có thể kết hợp thực hiện nhiều thủ pháp của xoa bóp bấm huyệt trong cùng một thời điểm và kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Bước 1: Sát khuẩn tay theo quy định, đeo găng tay.

Bước 2: Thoa bột talc/dầu xoa bóp lên vùng tiến hành kỹ thuật.

Bước 3: Thực hiện các thao tác kỹ thuật xoa bóp theo chỉ định. Yêu cầu đảm bảo về lực, tần suất, độ thuần thục, linh hoạt của động tác. Các kỹ thuật thường được sử dụng:

Kỹ thuật tác động lên da: xoa, xát, miết, phân, hợp, véo, vỗ, phát.

Kỹ thuật tác động lên cân cơ: day, bóp, đấm, chặt, lăn, vê, vờn.

Kỹ thuật tác động lên huyệt: day huyệt, ấn huyệt, bấm huyệt, không tiến hành thủ pháp bấm huyệt trên trẻ nhỏ < 72 tháng tuổi.

Kỹ thuật tác động lên khớp: vê khớp, vận động khớp, kéo giãn khớp, rung.

Trong quá trình tiến hành các kỹ thuật, cần vừa làm vừa theo dõi phản ứng của người bệnh đối với kỹ thuật. Nếu thấy chưa phù hợp (quá mạnh hoặc quá nhẹ, cần điều chỉnh lại lực tác động và tần suất cho phù hợp).

Kết thúc quy trình

Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật.

Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

Liệu trình điều trị

Mỗi ngày 1-2 lần. 2 - 45 lần/liệu trình.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật:

Choáng:

Triệu chứng: Người bệnh vã mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt, hoa mắt, chóng mặt.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Đau:

Triệu chứng: Người bệnh đau tăng tại vùng xoa bóp bấm huyệt, kích thích dãy dụa phản ứng lại thao tác của người làm thủ thuật.

Xử trí:

Xoa nhẹ vùng đau, giảm cường độ tác động lên vùng điều trị; có thể dừng thủ thuật nếu người bệnh quá nhạy cảm với các tác động trên cơ thể.

Cho người bệnh nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp.

Dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Bầm tím da:

Nguyên nhân: do tác động lực mạnh khi tiến hành thủ pháp day, ấn Xử trí: Tránh vùng bầm tím trong lần tiến hành kỹ thuật tiếp sau.

Khống chế lực tác động (nặng nhẹ theo lứa tuổi của người bệnh) khi tiến hành thủ pháp.

Gãy xương: thường gặp rạn, bong màng xương.

Nguyên nhân có thể do lực quá mạnh hoặc trẻ phản kháng. Xử trí: dừng thủ thuật, bảo vệ chi, kiểm tra thần kinh mạch máu, báo bác sĩ và chuyển đánh giá chấn thương; bất động, băng hoặc bó bột theo người có thẩm quyền, không tự nắn.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013), Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.

22 Cạo gió

Mã đề xuất QT YHCT 22 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Là phương pháp sử dụng những dụng cụ hoặc kết hợp với các dược liệu có tinh dầu cạo, xát lên vùng da ở một số bộ phận của cơ thể theo các kinh mạch giúp cho khí huyết của cơ thể được lưu thông.

2 Chỉ định

Các chứng đau như đau lưng, đau vai gáy, …

Nhiễm hàn cảm lạnh.

Cảm nhiệt.

3 Chống chỉ định

Các bệnh về máu: bệnh bạch cầu, giảm tiểu cầu, sốt xuất huyết, các bệnh lý xuất huyết khác, …

Người bệnh có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc.

Trẻ dưới 30 tháng tuổi không sử dụng thuốc có tinh dầu để thực hiện kỹ thuật.

4 Thận trọng

Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu nội khoa, ngoại khoa.

Vùng da cạo gió có tổn thương.

Trẻ em, phụ nữ có thai.

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, …

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp:

Bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên y, lương y, điều dưỡng phù hợp với phạm vi chuyên môn có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân lực hỗ trợ: Điều dưỡng.

5.2 Thuốc

Cảm lạnh phong hàn: rượu thuốc, dầu nóng, …

Cảm nóng: cồn, dầu gió, tinh dầu bạc hà, …

Hộp thuốc chống phản vệ.

5.3 Vật tư

Bông, gạc vô khuẩn, găng tay y tế.

Xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay, ...

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ cạo gió (có hình cung tròn, nhẵn nhụi như: nhẵn bạc, đồng tiền bằng bạc, thìa, miệng chén, sừng trâu, …).

Kẹp có mấu.

5.5 Người bệnh

Được khám, làm hồ sơ bệnh án theo quy định.

Được giải thích về quy trình kỹ thuật, hợp tác với thầy thuốc.

Được hướng dẫn tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp, bộc lộ vùng được điều trị.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ thông tin về người bệnh, chỉ định điều trị rõ ràng.

5.7 Thời gian thực hiện kỹ thuật

25 đến 30 phút/lần.

5.8 Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra phiếu chỉ định kỹ thuật đúng tên, tuổi, chẩn đoán, … của người bệnh.

Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra dị ứng, đúng thuốc hoặc vật tư, huyệt và bên, chỉ định, mức độ ổn định và phương tiện cấp cứu. Có sai khác phải giải quyết trước thực hiện.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1: Người bệnh nằm bộc lộ da vùng cần cạo gió.

Bước 2:

Sát trùng dụng cụ cạo gió trước khi dùng.

Bôi tinh dầu (rượu thuốc) lên da vùng cần cạo gió: dùng bông vô khuẩn thấm và bôi rượu thuốc hoặc tinh dầu lên da.

Bước 3:

Tay cầm dụng cụ cạo gió, để nghiêng góc 45 độ hoặc 90 độ rồi tiến hành cạo theo 1 chiều nhất định xuôi dọc chiều cơ thể từ trên xuống dưới (hoặc từ trong ra ngoài khi cạo ở vùng ngực). Chú ý dùng lực vừa và miết dài dụng cụ cạo gió.

Cạo lần lượt từng vùng cơ thể từ đầu, ngực bụng, lưng, chân tay. Mỗi vùng cạo không quá 10 phút, không được dùng lực quá mạnh tạo thành vết xước trên da.

Trong quá trình cạo gió, bổ sung tinh dầu lên vùng cạo gió khi cần thiết.

Kết thúc quy trình:

Đánh giá lại da và toàn trạng, giúp nghỉ ở tư thế thoải mái, tránh lạnh và quá nóng. Chỉ cho uống khi tỉnh, nuốt an toàn và không hạn chế dịch; không đắp kín nhằm ép ra mồ hôi. Ghi hồ sơ và dặn theo dõi phản ứng da.

Liệu trình điều trị:

Cạo gió 1 - 2 lần/ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của người bệnh.

Một liệu trình điều trị từ 1-3 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Choáng: Người bệnh hoa mắt chóng mặt, ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh.

Xử trí: dừng thủ thuật, ngắt nguồn điện hoặc nhiệt nếu có và xử lý kim an toàn; đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn, đặt tư thế phù hợp, báo bác sĩ, theo dõi sinh hiệu. Không cho uống khi giảm ý thức, nguy cơ sặc hoặc chưa nuốt an toàn. Chỉ bù dịch uống khi tỉnh, phù hợp bệnh nền và chỉ định.

Trầy xước da vùng cạo gió.

Xử trí: ngừng cạo gió. Khi cạo cần chú ý dùng lực vừa phải, quan sát vùng cạo gió.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Đau vùng cạo gió: giải thích cho người bệnh, dùng thuốc hóa dược (nếu cần).

Biến chứng muộn:

Nổi mẩn ngứa khi người bệnh dị ứng với thuốc sử dụng để cạo gió.

Xử trí: Dừng phương pháp hoặc đổi thuốc hoặc tinh dầu.

Ghi thời điểm, dấu hiệu bất thường, xử trí và đáp ứng; đánh giá trước kết thúc, bàn giao và hướng dẫn tái khám khi đau tăng, đỏ, sưng, sốt, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh. Thuốc giảm đau, kháng sinh, chống dị ứng hoặc corticoid chỉ theo bác sĩ, không dùng thường quy để thay đánh giá nguyên nhân.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013), Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học.

Bộ Y tế (2013), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu”.

Bộ Y tế. Quyết định 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; áp dụng cùng quy định thời điểm tại QĐ2149/QĐ-BYT ngày 15/7/2026.